

Nova Avaliação Geriátrica Ampla

Combo Nova AGA

Laudo Técnico

Logomarca do
serviço ou
profissional

AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA

1. PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA

Data: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

Sexo: _____

Profissão: _____ Aposentado: () Sim () Não

Idade: _____

Data de Nascimento: ____/____/____

Naturalidade: _____

Estado: _____ País: _____

Estado Civil: () Casado () Solteiro () Viúvo () Separado () Outros

Cor: () Leucoderma () Feoderma () Melanoderma

Escolaridade: _____

Endereço: _____

Telefone: () _____

Informante (se for o caso): Parentesco: _____

Cuidador: _____ Idade: _____ Sexo: _____

AGENDA DETALHADA DO PACIENTE/FAMÍLIA

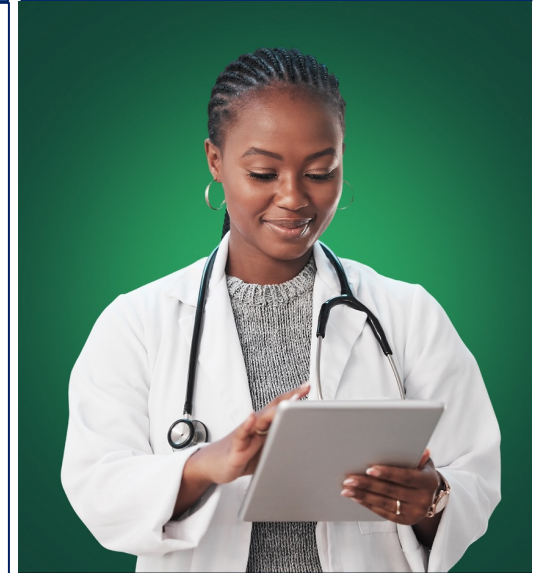
Lista de Problemas

Tutorial

Sumário

Conceito	3
Quando indicar a AGA?	3
Vulnerable Elderly Survey (VES-13)	5
Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20 (IVCF-20)	6
Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI/AB)	6
Avaliação Geriátrica Compacta de 10 minutos (AGC-10)	7
Estrutura	8
Avaliação Multidimensional da Saúde da Pessoa Idosa	8
Funcionalidade	9
Cognição	10
Humor/Comportamento	15
Mobilidade	15
Alcance, preensão e pinça	15
Capacidade aeróbica e muscular	15
Equilíbrio e marcha	15
Comunicação	16
Sistemas fisiológicos globais	17
Nutrição	17
Sono	17
Saúde Bucal	20
Sistemas fisiológicos propriamente ditos	20
Medicamentos	21
História pessoal e hábitos de vida	22
Fatores contextuais	22
Suporte familiar e social	22
Segurança ambiental	24
Saúde do Cuidador	24
Diagnóstico Geriátrico-Gerontológico	25
Diagnóstico Funcional Global	26
Clinical Frailty Scale (CFS), proposta por Rockwood (2005)	26
Escala Visual de Fragilidade Clínico Funcional, proposta por Moraes e Lanna (2016)	26
Lista de Problemas:	28
Plano de Cuidados Personalizado	28
Referências Bibliográficas	30

Treinamento Online



**Curso Online de
Treinamento da Nova AGA**
*Turmas regulares
Carga horária: 20h*

AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA

1. PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA

Data: ____ / ____ / ____

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

Sexo: _____

Profissão: _____ Aposentado: () Sim () Não

Idade: _____

Data de Nascimento: ____ / ____ / ____

Naturalidade: _____

Estado: _____ País: _____

Estado Civil: () Casado () Solteiro () Viúvo () Separado () Outros

Cor: () Leucoderma () Feoderma () Melanoderma

Escolaridade: _____

Endereço: _____

Telefone: () _____

Informante (se for o caso): Parentesco: _____

Cuidador: _____ Idade: _____ Sexo: _____

AGENDA DETALHADA DO PACIENTE/FAMÍLIA

Lista de Problemas

AVALIAÇÃO FUNCIONAL GLOBAL

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA BÁSICAS (AVD's básicas: AUTOCUIDADO)

ESCALA DE KATZ	
Atividade	Grau de dependência
Tomar banho	
Não recebe ajuda ou ajuda apenas em uma parte do corpo. Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo ou não toma banho sozinho,	Independente (0) Dependente (1)
Vestir-se (inclui pegar roupas nos armários e gavetas)	
Pega as roupas e veste-se completamente, auxílio para amarrar os sapatos ou não. Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece parcial ou completamente sem roupa.	Independente (0) Dependente (1)
Uso do vaso sanitário (ir ao banheiro, higiene e arrumar as roupas)	
Vai ao banheiro, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda - permitido uso de dispositivo de marcha e "comadre/papagaio." Recebe ajuda para ir ao banheiro, para limpar-se, ajeitar as roupas ou utilizar "comadre/ papagaio" ou não vai ao banheiro.	Independente (0) Dependente (1)
Transferência	
Deita-se ou sai da cama, senta-se ou levanta-se da cadeira sem auxílio - permitido dispositivo de marcha. Recebe ajuda para deitar-se e/ou sentar ou não sai da cama.	Independente (0) Dependente (1)
Continência	
Controla inteiramente a micção e evacuação. Episódios de incontinência ou necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação, uso de cateter ou é incontinente.	Independente (0) Dependente (1)
Alimentação	
Alimenta-se sem ajuda ou recebe auxílio apenas para cortar a carne ou passar manteiga no pão. Recebe ajuda para alimentar-se ou é alimentado parcial ou completamente por cateteres ou fluidos intravenosos.	Independente (0) Dependente (1)

Interpretação: pontuação varia de 0 a 6, sendo 0 indivíduos totalmente independentes e 6 aqueles totalmente dependentes.

Nota: independência significa a realização dos atos citados sem supervisão, orientação ou assistência pessoal ativa, exceto nos casos especificamente descritos abaixo. Esta avaliação é baseada no real desempenho e não na habilidade. Um paciente que se recusa a executar uma função é considerado como não a tendo executado, mesmo que se julgue ser ele capaz.

ESCALA DE LAWTON-BRODY	
Atividades Instrumentais de Vida Diária	
Usar o telefone	
Fazer compras	
Preparar refeições	
Tarefas domésticas	
Trabalhos manuais e pequenos reparos na casa	
Lavar roupas	
Meio de transporte (dirigir ou viajar sozinho de ônibus, trem, metrô e taxi)	
Uso de medicamentos	
Manuseio de dinheiro	
Pontuação de cada item: 1 ponto se incapaz; 2 pontos quando necessita de alguma ajuda; 3 pontos se totalmente capaz.	
Interpretação: o escore varia de 9 a 27 pontos, sendo 9 pontos: totalmente dependente; 10-24: parcialmente dependente; 25-27: independente.	

	Escore	Comentários
Índice de Pfeffer		
Índice de Barthel		

MOBILIDADE

Avaliação do Alcance/Preensão/Pinça

Avaliação funcional dos ombros () Normal () Anormal

Preensão manual e pinça () Normal () Anormal

Instrumentos Específicos		
	Escore	Comentários
Teste do Sentar e Levantar da Cadeira (5 movimentos))		
Força nas mãos		
Short Physical Performance Battery (SPPB)	Testes de Equilíbrio	
	Velocidade da Marcha	
	Levantar e Sentar da Cadeira (5x)	
	Escore total	
Timed Up and Go Test (TUG)		
Get Up and Go Test		
Escala de Equilíbrio e Marcha de Tinetti		
Outros:		

QUEDAS

História de quedas no último ano () sim () não

Número de quedas () 1 () 2 a 4 () ≥ 5

Repercussão funcional () sim () não

Especificar:

Causas/circunstâncias: 1) Sensação de desequilíbrio 2) Perda de consciência

Tempo de permanência no chão:

Necessidade de ajuda para levantar-se () sim () não

Continência Esfincteriana

	Sim	Não	Mecanismo
Incontinência urinária			
Incontinência fecal			

COMUNICAÇÃO

Visão		
Uso de lentes corretivas	() Sim	() Não
Teste Snellen (5 metros)	() $< 0,3$	() $> 0,3$
Dificuldade para ler jornais ou revistas	() Sim	() Não
Data da última visita ao Oftalmologista: ____/____/____		

Audição			Otosopia
Uso de prótese auditiva	() Sim	() Não	
Teste do sussuro (60cm de cada ouvido)	() Positivo	() Negativo	
Dificuldade para conversação com 3 ou mais pessoas	() Sim	() Não	
Data da última visita ao Otorrinolaringologista: ____/____/____			

Fala/motricidade Orofacial		
Produção oral		
Deglutição		

REVISÃO DOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS GLOBAIS

SAÚDE BUCAL

Mini-Avaliação da Saúde bucal

Observar a presença de:	Sim	Não
Diminuição da quantidade de alimentos ou mudança no tipo de alimentação por causa dos dentes?		
Problemas de mastigação		
Sensibilidade exagerada a alimentos ou líquidos nos dentes ou gengivas?		
Edentulismo		
Prótese dentária		
Xerostomia		
Feridas ou lesões na mucosa oral ou língua		
Sangramento gengival		
Oroscopia:		
Data da última visita ao dentista:		

NUTRIÇÃO

Instrumentos Específicos

	Score	Comentários
Peso		
Estatura		
IMC		
Circunferência da Panturrilha		
Mini-Avaliação Nutricional (MAN)	Triagem	
	Avaliação Global	
Outros		

SONO

Rastreamento dos Transtornos de Sono-Vigília no Idoso

Horários do sono noturno	Início (hora de deitar para dormir):		
	Término:		
	Duração total:		
	Eficiência do sono (tempo real de sono: tempo dormido/tempo na cama):		
	Número e duração dos despertares noturnos:		
	Latência do sono (Tempo necessário para adormecer):		
	Latência do sono após despertar noturno:		
		Sim	Não
Você está satisfeito (a) com o seu sono? <i>Considerar resposta do paciente e/ou do cuidador/familiar</i>			
Relato de "soneca" (sesta) após o almoço ou durante o dia? Frequência: Duração:			
Apresenta sonolência excessiva, cochilos ou fadiga que interferem no desempenho das tarefas do dia?			
O parceiro, cuidador ou outros observadores relatam a presença de:	Comportamentos incomuns durante o sono (agitação psicomotora, agressividade, movimentação anormal, sonambulismo, etc)		
	Alterações respiratórias, como ronco excessivo ou pausa na respiração (apneias testemunhadas, asfixia, sensação de sufocação, "engasgo" noturno ou respiração ofegante), com duração ≥ 10 segundos.		
Relato de movimentação anormal das pernas ou outras partes do corpo para alívio de sensações desconfortáveis.			
Presença de sintomas matinais, como:	Boca seca (xerostomia)		
	Cefaléia		
Duração da sintomatologia superior a 3 meses			
Descrição detalhada do transtorno do sono-vigília:			

REVISÃO DOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS CLÁSSICOS

	Anamnese	Exame Físico	Exames Complementares
Pele/Anexos			
Sistema Cardiovascular			
Sistema Respiratório			
Sistema Digestivo			
Sistema Genitourinario			
Sistema Locomotor			
Sistema Neurológico			
Sistem Endócrino-Metabólico			
Sistema Hematopoiético			

MEDICAMENTOS

[illegible]

HISTÓRIA PESSOAL E HÁBITOS DE VIDA

TABAGISMO () sim () não

Número de cigarros/dia: Duração/anos:

Outros:

ETILISMO () sim () não

Tipo de bebida: _____ Dose diária: _____ Duração/anos: _____

CAGE (triagem: teste positivo com 1 resposta afirmativa)

1. Você já sentiu a necessidade de reduzir ou suspender o álcool (Cut down) ?
2. Alguém já o criticou pelo ato de beber?
3. Sente-se culpado (Guilty) por beber?
4. Costuma beber logo pela manhã (Eye-opener)

Drogas ilícitas: () Sim () Não

ATIVIDADE FÍSICA: () sim () não

- Frequência () regular () ocasional () raro

• Tipo: _____

- Orientada por profissional() Sim () Não

DIREÇÃO VEICULAR () sim () não

HOSPITALIZAÇÕES CLÍNICAS (DIAGNÓSTICO/ANO)

1 _____

2 _____

3 _____

CIRURGIAS PRÉVIAS

1 _____

2 _____

3 _____

FATORES CONTEXTUAIS

Constituição e Funcionamento Familiar					
APGAR da Família	0 a 4 pontos	5 a 6 pontos		7 a 10 pontos	
Nome	Parentesco	Sexo	Estado Civil	Reside com o idoso	
				Sim	Não

Avaliação do Suporte Familiar		Sim	Não
Moradia	O sr(a) mora sozinho?		
	O sr(a) reside com familiares ou amigos?		
	O sr(a) reside em ILPI?		
Cônjuge ou Companheiro	O sr(a) tem cônjuge ou companheiro?		
	O sr(a) ficou viúva(o) no último ano?		
Apoio nas atividades de vida diária	O sr(a) tem familiares/cuidadores ou amigos com disponibilidade para atendê-lo plenamente na realização das tarefas do cotidiano, em caso de necessidade?		
Interação familiar e comunitária	O sr(a) recebe ou faz visitas a familiares, amigos ou vizinhos com regularidade?		
	O sr (a) sente falta de maior convívio com familiares ou amigos?		
Sobrecarga familiar	O sr(a) é responsável pelo cuidado de pessoas dependentes no seu domicílio?		
	O sr(a) reside com pessoas que possam causar desorganização no convívio familiar?		

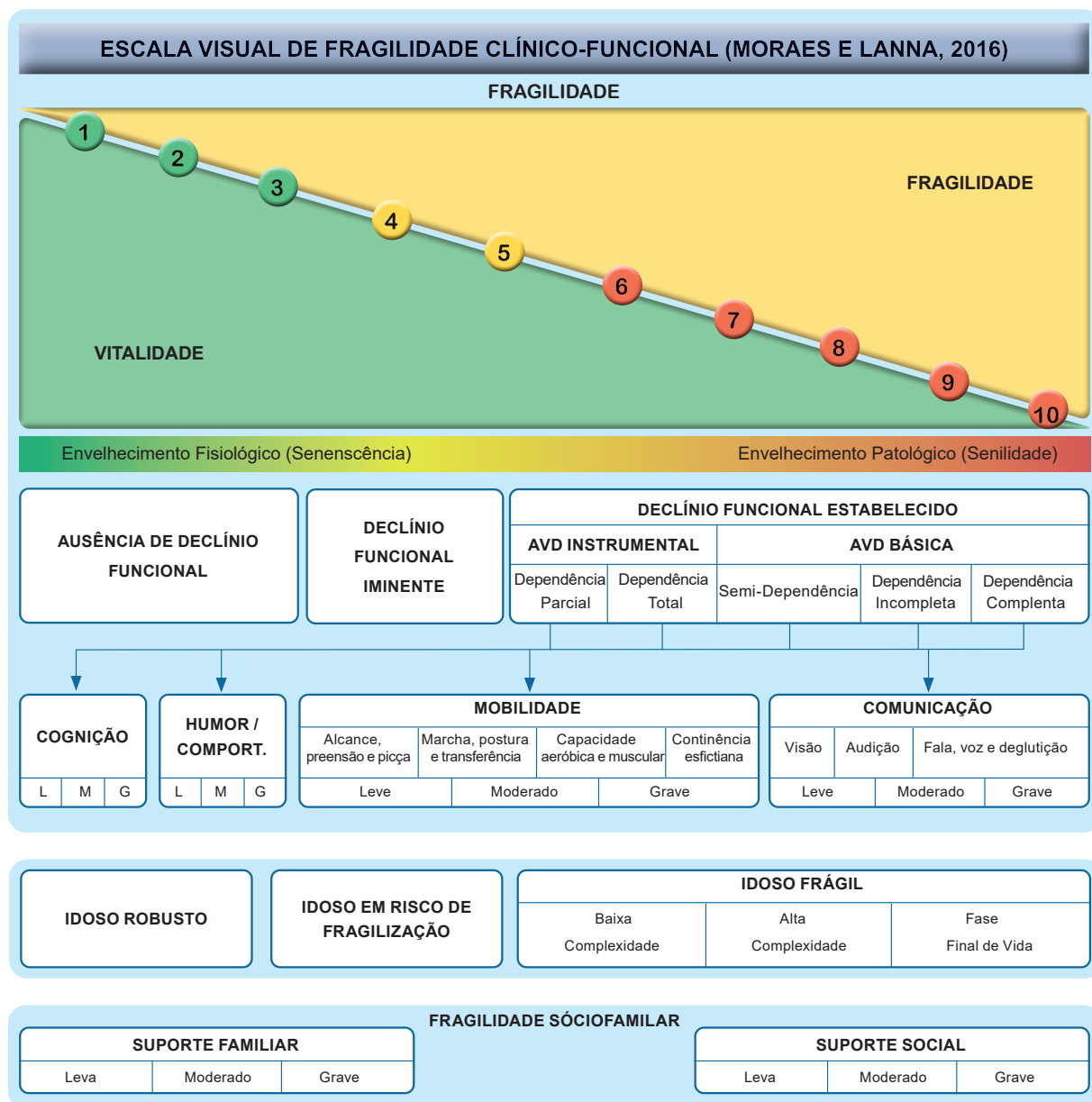
Avaliação do Suporte Social		Sim	Não
Renda	O sr(a) tem acesso à renda própria, do tipo benefício previdenciário?		
	O sr(a) tem acesso à renda própria, do tipo benefício assistencial (LOAS/BPC)?		
	O sr(a) tem acesso à renda de terceiros, em caso de necessidade?		
Escolaridade	O sr(a) é capaz de ler e escrever?		
Condições da Moradia	O sr(a) tem moradia própria?		
	A sua moradia está em boas condições de organização, segurança e higiene?		
Participação Social	O sr(a) participa de eventos ou atividades extradomiciliares ou comunitária ou rede social, como trabalho, família, igreja, grupo de convivência, lazer, etc?		

	Escore	Comentários
Tilburg Frailty Indicator (TFI)		
Groningen Frailty Indicator		
Makizako Social Frailty Index		
Social Frailty Screening Index		

Avaliação do Cuidador	
Idade	
Vínculo	
Relação conflituosa?	
Capaz para os cuidados?	
Tem ajuda de outras pessoas?	
Suspeita de abuso/negligência?	
Sinais de sobrecarga?	
Escore na Escala de Zarit	

2. DIAGNÓSTICO GERIÁTRICO-GERONTOLÓGICO

2.1 DIAGNÓSTICO FUNCIONAL GLOBAL



*VS-Frailty 2016: permissão concedida por Moraes e Lanna

FRAGILADE CLÍNICO-FUNCIONAL BrazilianPortuguese – Escla Clínica de Fragilidade	
	1. Muito Ativo
	2. Ativo
	3. Regular
	4. Vulnerável
	5. Levemente Frágil
	6. Moderadamente Frágil
	7. Gravemente Frágil
	8. Muito Gravemente (Extremamente) Frágil
	9. Doente Terminal

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL GLOBAL									
FUNÇÕES		PRESENÇA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL							
		NÃO	SIM						
FUNCIONALIDADE GLOBAL		AVD Instrumental		Dependência parcial		Dependência completa			
		AVD Básica		Semi-Dependência		Dependência Incompleta		Dependência Completa	
SISTEMAS FUNCIONAIS PRINCIPAIS	Cognição								
	Humor/Comportamento								
	MOBILIDADE	Alcance / Preensão / Pinça							
		Postura/ Marcha/ Transferência		Instabilidade Postural			Imobilidade		
		Capacidade Aeróbica/Muscular		Fenótipo de Fried			Sarcopenia		
		Continência Urinária		Transitória	Permanente				
					Urgência	Esforço	Transbordamento	Funcional	
		Continência Fecal							
		COMUNICAÇÃO	Visão						
	Audição								
	Fala, voz e deglutição								
Sistemas Fisiológicos Principais		Saúde Bucal							
		Nutrição							
		Sono							
SUPORTE SOCIAL E FAMILIAR		Suporte Familiar		Leve	Moderado		Grave		
		Suporte Social		Leve	Moderado		Grave		
		Segurança Ambiental							

2.2 LISTA DE PROBLEMAS/DEMANDAS DO PACIENTE E/OU DA FAMÍLIA

3. PLANO DE CUIDADOS PERSONALIZADO

3.1 DEFINIÇÃO COMPARTILHADA DA PROPORCIONALIDADE TERAPÊUTICA:

3.2 METAS TERAPÊUTICAS:

Prioridade 1: Intervenções capazes de reduzir o declínio funcional + Intervenções capazes de confortar o paciente e/ou família

Prioridade 2: Intervenções curativas ou capazes de modificar a história natural das doenças, reduzindo o risco de declínio funcional

Prioridade 3: Intervenções preventivas e direcionadas a fatores de risco

3.3 AÇÕES CURATIVAS E/OU PALIATIVAS

Tratamento Farmacológico Atual:

[illegible]

Tratamento Farmacológico Proposto:

Medicamento / Nome comercial	Horário de administração e Intervalo	Via de uso	Dose / Quantidade	Orientações

Tratamento Não-Farmacológico Proposto / Autocuidado Apoiado / Cuidado Familiar:

3.4 INTERVENÇÕES REABILITADORAS

Reabilitação Física	Mobilidade	Alcance/Preensão/Pinça
		Postura/Marcha/ Transferência
		Capacidade aeróbica
	Funções Neurovegetativas	Continência esfinteriana
		Deglutição
	Comunicação	Visão
		Audição
		Fala/Voz
Reabilitação Cognitiva, Comportamental ou do Sono	Cognição	
	Humor/Comportamento	
	Sono	
Reabilitação Sociofamiliar	Suporte Familiar	
	Suporte Social	
	Reabilitação Ambiental	

Especialidade	Grau de Prioridade
Enfermagem	
Fisioterapia	
Terapia ocupacional	
Fonoaudiologia	
Nutrição	
Psicologia	
Serviço social	
Farmácia	
Educação Física	
Odontologia	
Musicoterapia	
Outros	

Metas e Estratégias da Reabilitação:

3.5 AÇÕES PREVENTIVAS/PROMOCIONAIS

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS		SIM	NÃO	Observações
DOENÇA CARDIOVASCULAR	Há indicação de anti-agregante plaquetário?			
	Há indicação de estatina?			
	Ultrassom abdominal para diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal?			

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS			SIM	NÃO	Observações
IMUNIZAÇÃO	Anti-Influenza				
	Anti-Pneumocócica				
	Dupla Tipo Adulto				
	Anti-Amarílica				
	Anti-Zoster				
	Anti-COVID-19				
RASTREAMENTO DE CÂNCER	Cólon-retal	PSOF (3 amostras independentes)			
		Colonoscopia			
		Outros:			
	Colo de útero (Papanicolau)				
	Próstata (PSA)				
	Pulmão				
OSTEOPOROSE / FRATURA DE FRAGILIDADE	Há indicação para solicitação de densitometria óssea?				
	Há indicação de suplementação de vitamina D3?				
	Há indicação de suplementação de cálcio?				
	Há indicação para tratamento farmacológico da osteoporose?				
ACONSELHAMENTO (Mudança de estilo de vida)	Aconselhamento para atividade física				
	Aconselhamento para prevenção de quedas				
	Aconselhamento para prevenção ou tratamento do tabagismo				
	Aconselhamento para prevenção ou tratamento do alcoolismo				
	Aconselhamento nutricional				

3.6 ENCAMIHAMENTOS FINAIS

	Sim	Não	Justificativa
Especialidades Médicas			
Equipe Interdisciplinar			
Propedêutica Complementar			
Planejamento do Acompanhamento Longitudinal			

Nova Avaliação Geriátrica Ampla (Nova AGA)

Com o objetivo de ampliar mais ainda o seu alcance e incorporar novas tecnologias do cuidado centrado na pessoa, a SBGG apresenta a Nova Avaliação Geriátrica Ampla (Nova AGA), durante o XXIII Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. Esta nova versão atualizada da AGA lançada há cerca de 10 anos propõe uma estrutura composta pela **Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa**, capaz de definir o **Diagnóstico Geriátrico-Gerontológico**, a partir do qual se elabora um **Plano de Cuidados Personalizado**, com o objetivo de melhorar a vida da pessoa idosa e sua família, oferecendo a melhor experiência do cuidado e o menor custo assistencial.

A SBGG disponibiliza Laudo Técnico da Nova AGA, juntamente com o manual em que se discute as diretrizes de sua utilização. Outra iniciativa é oferecer treinamentos regulares, utilizando a tecnologia do ensino à distância, para todos os interessados, conforme critérios estabelecidos pela diretoria da SBGG.

A especialidade da Geriatria conta com o procedimento Avaliação Geriátrica Ampla – AGA, procedimento este já inserido na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM. É fundamental para avaliação e seguimento clínico dos pacientes idosos, que por características intrínsecas ao processo do envelhecimento humano e sua susceptibilidade e vulnerabilidade para múltiplas condições médicas, de caráter biológico, psicológico e/ou social, necessitam de uma avaliação médica mais abrangente.

A razão destes cuidados traduz-se pelo zelo com um instrumento de avaliação já inserido na CBHPM, e que está em processo de consolidação junto às operadoras de saúde para que se sensibilizem e iniciem o processo de inserção deste instrumento nos pagamentos aos médicos e equipe interdisciplinar conveniados.

Convidamos os colegas geriatras e especialistas em gerontologia interessados nessa temática a se incorporarem à comissão, para que possamos aperfeiçoá-la continuamente, transformando-a em um instrumento de qualificação da prática geriátrico-gerontológica e de melhoria da qualidade de vida da população idosa brasileira.

Comissão Revisora:

- Edgar Nunes de Moraes
- Renato Bandeira de Mello
- Marlon Juliano Romero Aliberti

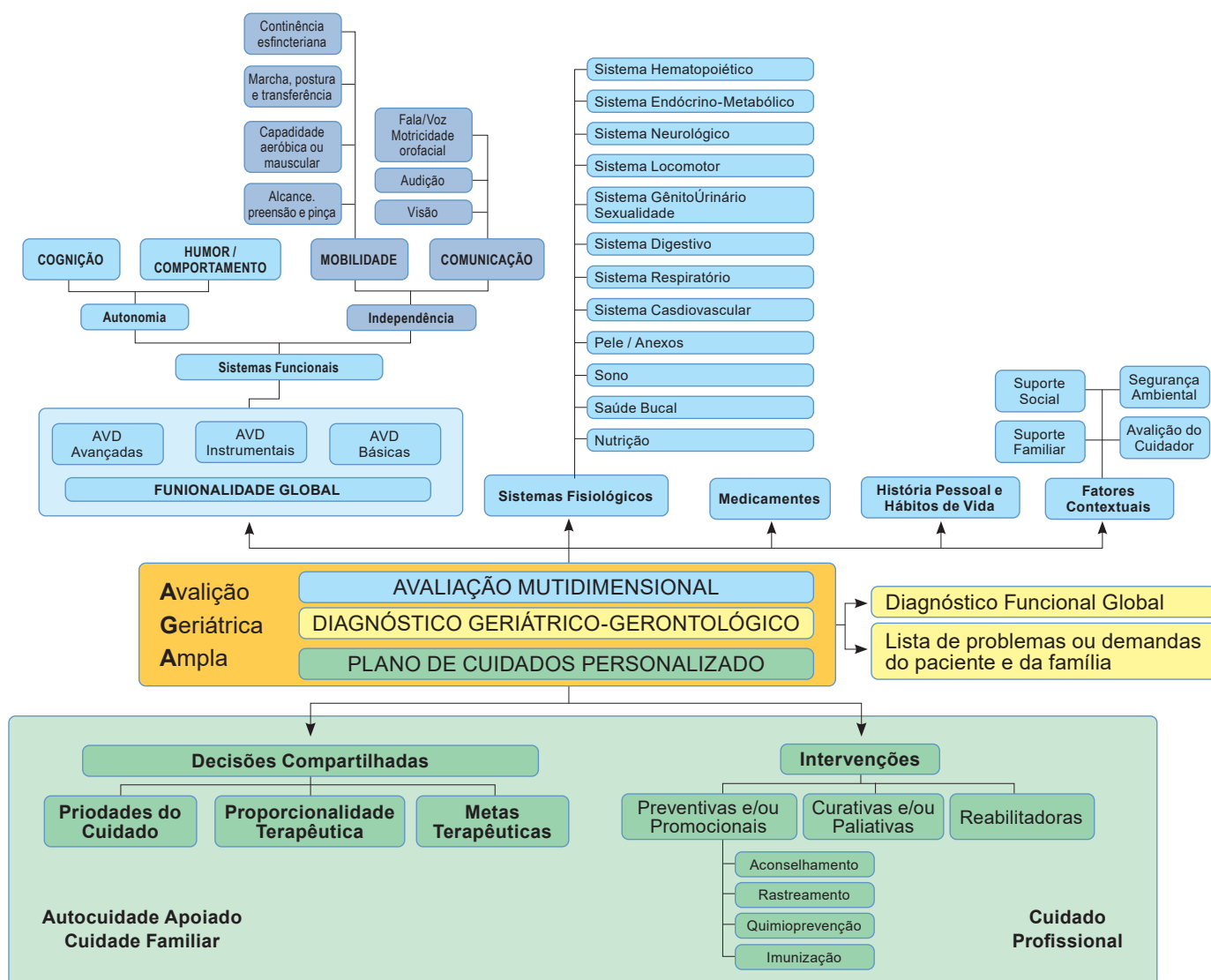
Sumário

Conceito	3
Quando indicar a AGA?	3
Vulnerable Elderly Survey (VES-13)	5
Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20 (IVCF-20)	6
Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI/AB)	6
Avaliação Geriátrica Compacta de 10 minutos (AGC-10)	7
Estrutura	8
Avaliação Multidimensional da Saúde da Pessoa Idosa	8
Funcionalidade	9
Cognição	10
Humor/Comportamento	15
Mobilidade	15
Alcance, preensão e pinça	15
Capacidade aeróbia e muscular	15
Equilíbrio e marcha	15
Comunicação	16
Sistemas fisiológicos globais	17
Nutrição	17
Sono	17
Saúde Bucal	20
Sistemas fisiológicos propriamente ditos	20
Medicamentos	21
História pessoal e hábitos de vida	22
Fatores contextuais	22
Suporte familiar e social	22
Segurança ambiental	24
Saúde do Cuidador	24
Diagnóstico Geriátrico-Gerontológico	25
Diagnóstico Funcional Global	26
Clinical Frailty Scale (CFS), proposta por Rockwood (2005)	26
Escala Visual de Fragilidade Clínico Funcional, proposta por Moraes e Lanna (2016)	26
Lista de Problemas:	28
Plano de Cuidados Personalizado	28
Referências Bibliográficas	30

Conceito

A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é um procedimento diagnóstico e terapêutico, com caráter multidimensional e interdisciplinar, com o objetivo de avaliar as capacidades física, funcional, psicológica e social do indivíduo, a fim de desenvolver um plano de cuidados coordenado e integrado para o tratamento e acompanhamento a longo prazo (Figura 1). Assim, a AGA não se limita simplesmente à avaliação, mas também direciona um plano de cuidados holístico com intervenções tangíveis, capazes de maximizar a saúde geral dos idosos (Choi, 2023; Veronesi, 2022; Brigs, 2022; Garrardi 2020; Ellis 2011; Rubenstein 1991).

Figura 1 Avaliação Geriátrica Ampla



Quando indicar a AGA?

A AGA pode ser realizada em todo indivíduo com 60 anos ou mais, mas a relação custo-benefício deste procedimento é mais evidente na população idosa que apresenta suspeita de fragilidade identificada por meio dos instrumentos de **estratificação de risco** ou na presença de algumas condições clínicas, como quedas, confusão mental, mobilidade reduzida, incontinência esfincteriana, pós alta hospitalar e nos idosos institucionalizados (*British Geriatrics Society*, 2019). Cabe ressaltar que o conceito de fragilidade é amplo e sua operacionalização não é consensual. Na perspectiva da AGA, optamos por considerar o “idoso frágil” como sendo aquele indivíduo com 60 anos ou mais que tenha qualquer condição de saúde caracterizada pela redução da capacidade de adaptação às agressões biopsicossociais e, conseqüentemente, maior risco de desfechos adversos, como declínio funcional, institucionalização, internação e óbito.

Segundo Mendes (2019), a estratificação de risco das condições crônicas é fundamental para o planejamento e implementação de políticas de saúde capazes de assegurar o “Cuidado Certo” ou “Cuidado de Alto Valor”, definido com o “cuidado ofertado para otimizar a saúde e o bem-estar, por meio da prestação da atenção que é necessária, desejada, clinicamente efetiva, acessível, equitativa e responsável no uso dos recursos” (Saini, 2017). Nas condições crônicas de saúde, o espectro de gravidade é extremamente variável e as respostas do sistema de saúde devem ser condizentes com as necessidades do indivíduo (equidade). Indivíduos com condições crônicas altamente complexas, como ocorre nos idosos frágeis, exigem respostas focadas na utilização de tecnologias de gestão de caso realizada por equipes geriátrico-gerontológicas especializadas. Nestes casos, a AGA torna-se a melhor estratégia de gestão de caso.

Existem vários instrumentos que podem ser utilizados para a estratificação de risco da pessoa idosa e não há evidências claras de superioridade entre elas. Sugerimos a utilização de instrumentos de rápida aplicação (5 a 10 minutos) e que possam ser utilizados por todos os profissionais da atenção primária à saúde (APS). No Brasil, os instrumentos de rastreamento de fragilidade mais utilizados são:

Vulnerable Elderly Survey (VES-13):

O VES-13 avalia a idade, autopercepção da saúde, limitação física e incapacidades. O questionário é composto por 13 questões e cada questão recebe uma determinada pontuação (Figura 2). O somatório final pode variar de 0 a 10 pontos, sendo que idosos com pontuação final igual ou superior a três pontos apresentam um risco de 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois anos (idosos de alto risco), quando comparado com idosos com pontuação ≤ 2 pontos, independentemente do sexo e do número ou tipo de comorbidades presentes (Saliba, 2001; Maia, 2012). É o instrumento recomendado na Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (Brasil, 2014).

Figura 2: Vulnerable Elderly Survey

APÊNDICE A - Versão Final do VES-13

1. Idade _____

PONTUAÇÃO: 1 PONTO PARA IDADE 75-84
3 PONTOS PARA IDADE ≥ 85

2. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:

Ruim* (1 PONTO)
Regular* (1 PONTO)
Boa
Muito Boa ou
Excelente

PONTUAÇÃO: 1 PONTO PARA REGULAR ou RUIM

3. Em média, quanta dificuldade você tem para fazer as seguintes atividades físicas:

	Nenhuma dificuldade	Pouca dificuldade	Média dificuldade	Muita dificuldade*	Incapaz de fazer*
Curvar-se, agachar ou ajoelhar-se	()	()	()	()*	()*
Levantar ou carregar objetos com peso aproximado de 5 quilos?	()	()	()	()*	()*
Elevar ou estender os braços acima do nível do ombro?	()	()	()	()*	()*
Escrever ou manusear e segurar pequenos objetos?	()	()	()	()*	()*
Andar 400 metros (aproximadamente quatro quarteirões)?	()	()	()	()*	()*
Fazer serviço doméstico pesado como esfregar o chão ou limpar janelas?	()	()	()	()*	()*

PONTUAÇÃO: 1 PONTO PARA CADA RESPOSTA "MUITA DIFICULDADE*" OU "INCAPAZ DE FAZER*" NAS QUESTÕES 3a ATÉ 3f. CONSIDERAR NO MÁXIMO DE 2 PONTOS.

4. Por causa de sua saúde ou condição física, você tem alguma dificuldade para:

a. fazer compras de itens pessoais (como produtos de higiene pessoal ou medicamentos?)

() SIM → Você recebe ajuda para fazer compras?	() SIM*	() NÃO
() NÃO		
() NÃO FAÇO COMPRAS → Isto acontece por causa de sua saúde?	() SIM*	() NÃO

b. lidar com dinheiro (como controlar suas despesas ou pagar contas)?

() SIM → Você recebe ajuda para lidar com dinheiro?	() SIM*	() NÃO
() NÃO		
() NÃO LIDO COM DINHEIRO → Isto acontece por causa de sua saúde?	() SIM*	() NÃO

c. atravessar o quarto andando? É PERMITIDO O USO DE BENGALA OU ANDADOR.

() SIM → Você recebe ajuda para andar?	() SIM*	() NÃO
() NÃO		
() NÃO ANDO → Isto acontece por causa de sua saúde?	() SIM*	() NÃO

d. realizar tarefas domésticas leves (como lavar louça ou fazer limpeza leve)?

() SIM → Você recebe ajuda para tarefas domésticas leves?	() SIM*	() NÃO
() NÃO		
() NÃO FAÇO TAREFAS DOMÉSTICAS LEVES → Isto acontece por causa de sua saúde?	() SIM*	() NÃO

e. tomar banho de chuveiro ou banheira?

() SIM → Você recebe ajuda para tomar banho de chuveiro ou banheira? () SIM* () NÃO

() NÃO

() NÃO TOMO BANHO DE CHUVEIRO OU BANHEIRA → Isto acontece por causa de sua saúde? () SIM* () NÃO

PONTUAÇÃO: CONSIDERAR 4 PONTOS PARA UMA OU MAIS RESPOSTAS "SIM"* NAS QUESTÕES 4a ATÉ 4e

CLASSIFICAÇÃO FINAL:
NÃO VULNERÁVEL = pontuação ≤ 3
VULNERÁVEL = pontuação ≥ 3

Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional 20 (IVCF-20):

O IVCF-20 avalia a idade, percepção da saúde, AVD instrumentais, AVD básicas, cognição, humor, mobilidade (alcance, preensão e pinça; capacidade aeróbica/muscular/nutrição; alterações da marcha; quedas e continência esfincteriana), comunicação (visão e audição) e comorbidades múltiplas (polifarmácia, polipatologia e internação recente). O questionário é composto por 20 questões, cuja pontuação final varia de 0 a 40 pontos. O risco de fragilidade é diretamente proporcional à pontuação final no questionário. Assim, os idosos podem ser estratificados como de baixa (0 a 6 pontos), moderada (7 a 14 pontos) e alta vulnerabilidade (≥ 15 pontos) clínico funcional (Moraes, 2016; Moraes, 2020; www.ivcf20.org). É o instrumento recomendado pela Nota Técnica do Ministério da Saúde, em parceria com Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (Brasil, 2019).

Figura 3: Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE CLÍNICO FUNCIONAL-20 (IVCF-20) www.ivcf20.org			
IDADE	1. Qual é a sua idade?	() 60 a 74 anos ⁰	
		() 75 a 84 anos ¹	
		() ≥ 85 anos ³	
PERCEPÇÃO DA SAÚDE	2. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde é:	() Excelente, muito boa ou boa ⁰	
		() Regular ou ruim ¹	
AVD Instrumental <i>A pontuação máxima do item é de 4 pontos, mesmo que o idoso tenha respondido sim para todas as questões 3, 4 e 5.</i>	3. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de fazer compras?	() Sim ⁴ () Não ou não faz compras por outros motivos que não a saúde	
	4. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de controlar seu dinheiro, gasto ou pagar as contas de sua casa?	() Sim ⁴ () Não ou não controla o dinheiro por outros motivos que não a saúde	
	5. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer limpeza leve?	() Sim ⁴ () Não ou não faz mais pequenos trabalhos domésticos por outros motivos que não a saúde	
	6. Por causa de sua saúde ou condição física, você deixou de tomar banho sozinho?	() Sim ⁶ () Não	
COGNIÇÃO	7. Algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido?	() Sim ¹ () Não	
	8. Este esquecimento está piorando nos últimos meses?	() Sim ¹ () Não	
	9. Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?	() Sim ² () Não	
HUMOR	10. No último mês, você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança?	() Sim ² () Não	
	11. No último mês, você perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	() Sim ² () Não	
MOBILIDADE	Alcance, preensão e pinça	12. Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? () Sim ¹ () Não	
		13. Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? () Sim ¹ () Não	
	Capacidade aeróbica e/ou muscular	14. Você tem alguma das três condições abaixo relacionadas? () Sim ² () Não • Perda de peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano ou 6 kg nos últimos 6 meses ou 3 kg no último mês () • Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 22 kg/m ² () • Circunferência (perímetro) da panturrilha a < 31 cm () • Tempo gasto no teste de velocidade da marcha (4m) > 5 seg ()	
	Marcha	15. Você tem dificuldade para caminhar capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? () Sim ² () Não	
		16. Você teve duas ou mais quedas no último ano? () Sim ² () Não	
	Continência Esfincteriana	17. Você perde urina ou fezes, sem querer, em algum momento? () Sim ² () Não	
	COMUNICAÇÃO	Visão	18. Você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de óculos ou lentes de contato. () Sim ² () Não
		Audição	19. Você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? É permitido o uso de aparelhos de audição. () Sim ² () Não
COMORBIDADE MÚLTIPLA		20. Você tem alguma das três condições abaixo relacionadas? () Sim ⁴ () Não • Cinco ou mais doenças crônicas. • Uso regular de cinco ou mais medicamentos diferentes, todo dia. • Internação recente, nos últimos 6 meses.	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40			
ESTRATIFICAÇÃO CLÍNICO-FUNCIONAL DO IDOSO		• 0 a 6 pontos: BAIXA vulnerabilidade clínico-funcional • 7 a 14 pontos: MODERADA vulnerabilidade clínico-funcional • ≥ 15 pontos: ALTA vulnerabilidade clínico-funcional	

Moraes EN et al, Rev Saude Publica. 2016; 50:8;
Moraes EN et al, Rev Fac Ciênc Med Sorocaba, 22(1):31-5, 2020;
Faller JW et al, PLoS One. 2019 Apr 29;14(4): 4. Ribeiro ER, Rev Bras Enferm, 2021;74.

Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (AMPI/AB):

A AMPI-AB avalia a idade, autopercepção da saúde, suporte social, condições crônicas, medicamentos, internações, quedas, visão, audição, limitação física, cognição, humor, AVD básicas, AVD instrumentais, incontinência, perda de peso não intencional e condições bucais (Saraiva, 2020). O questionário é composto por 17 questões e a pontuação varia de 0 a 21 pontos. O instrumento define três estratos de idosos, conforme a pontuação final: 0 a 5 pontos (idoso saudável), 6 a 10 pontos (idoso pré-frágil) e ≥ 11 pontos (idoso frágil) (Saraiva, 2020). É o instrumento de estratificação de risco recomendado pela Secretária Municipal de Saúde de São Paulo.

Figura 4: AMPI-AB

AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA NA ATENÇÃO BÁSICA (AMPI-AB)									
NOME:						DN:			
NOME SOCIAL:						SEXO: F () M ()			
RAÇA/COR: () Branca () Preta () Amarela () Parda () Indígena						CNS:			
ENDEREÇO:						TEL:			
UBS:			Aplicação: () Próprio Idoso () Cuidador/Responsável			Aplicação: () Presencial () Telefone			
AMPI-AB: QUESTIONÁRIO MULTIDIMENSIONAL									PONTUAÇÃO
1	Idade	Qual a sua idade?	() 60 - 74 (0 PONTO)	() 75 - 89 (1 PONTO)	() 90 ou + (2 PONTOS)				
2	Auto Percepção da saúde	Em geral, comparado com outras pessoas de sua idade, o(a) Sr.(a.) diria que sua saúde é:	() Muito boa / boa (0 PONTOS)	() Regular/ ruim / muito ruim (1 PONTO)					
3	Suporte Social	O(A) Sr.(a.) mora sozinho?	() NÃO (0 PONTO)	() SIM (1 PONTO)					
4	Condições Crônicas	O(A) Sr.(a.) teve/tem algumas dessas condições abaixo?	() NENHUMA (0 PONTO)	() 1 ou 2 (1 PONTO)	() 3 ou + (2 PONTOS)				
☐ Diabetes mellitus, ☐ Hipertensão arterial sistêmica, ☐ Acidente vascular encefálico, ☐ Doença arterial coronariana, ☐ Doenças vasculares, ☐ Lesão por pressão, ☐ Anemia, ☐ Asma, ☐ Doença pulmonar obstrutiva crônica, ☐ Úlcera péptica, ☐ Osteoartrose, ☐ Obesidade, ☐ Neoplasia, ☐ Demência, ☐ Epilepsia, ☐ Depressão, ☐ Doença de Parkinson, ☐ DST/HIV/AIDS, ☐ Amputação de membro, ☐ Tabagismo/Alcoolismo/Outras drogas e ☐ Dor crônica.									
5	Medicamentos	Quantos medicamentos o(a) Sr.(a.) toma ao dia?	() 1 a 4 (0 PONTO)	() 5 ou + (1 PONTO)					
6	Internações	Quantas vezes o(a) Sr.(a.) ficou internado(a) nos últimos 12 meses?	() NENHUMA (0 PONTO)	() 1 INTERNAÇÃO (1 PONTO)	() 2 INTERNAÇÕES OU + (2 PONTOS)				
7	Quedas	Quantas vezes o(a) Sr.(a.) caiu nos últimos 12 meses?	() NENHUMA (0 PONTO)	() 1 EPISÓDIO (1 PONTO)	() 2 EPISÓDIOS OU + (2 PONTOS)				
8	Visão	O(A) Sr.(a.) tem alguma dificuldade para enxergar? (mesmo usando óculos)	() NÃO (0 PONTO)	() SIM (1 PONTO)					
9	Audição	O(A) Sr.(a.) tem alguma dificuldade para ouvir ou as pessoas acham que o(a) senhor(a) ouve mal?	() NÃO (0 PONTO)	() SIM (1 PONTO)					
10	Limitação Física	Verificar se o(a) idoso(a) é capaz de tocar a nuca com ambas as mãos.	SIM ()	NÃO ()	() SIM para todos os itens (0 PONTO) () NÃO em 1 a 4 itens (1 PONTO)				
		Verificar se o(a) idoso(a) é capaz de apanhar um lápis sobre a mesa com uma das mãos e colocá-lo de volta.	SIM ()	NÃO ()					
		Perguntar: o(a) Sr.(a.) consegue andar 400 metros (aproximadamente quatro quarteirões)?	SIM ()	NÃO ()					
		Perguntar: o(a) Sr.(a.) consegue sentar-se ou levantar-se sem dificuldade?	SIM ()	NÃO ()					
11	Cognição	O(A) Sr.(a.) acha ou algum familiar/amigo falou que o(a) Sr.(a.) está ficando esquecido?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 3 itens (1 PONTO)				
		O esquecimento está piorando nos últimos meses?	SIM ()	NÃO ()					
		O esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano?	SIM ()	NÃO ()					
12	Humor	No último mês, o(a) Sr.(a.) sentiu desânimo, tristeza ou desesperança?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 2 itens (1 PONTO)				
		No último mês, o(a) Sr.(a.) perdeu o interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas?	SIM ()	NÃO ()					
13	Atividades Básicas da Vida Diária - ABVD	O(a) Sr.(a.) precisa de ajuda para sair da cama?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 4 itens (1 PONTO)				
		O(a) Sr.(a.) precisa de ajuda para vestir-se?	SIM ()	NÃO ()					
		O(a) Sr.(a.) precisa de ajuda para alimentar-se?	SIM ()	NÃO ()					
		O(a) Sr(a) precisa de ajuda para tomar banho?	SIM ()	NÃO ()					
14	Atividades Instrumentais da Vida Diária - AIVD	O(a) Sr.(a.) precisa de ajuda para realizar atividades fora de casa?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 2 itens (1 PONTO)				
		O(a) Sr.(a.) precisa de ajuda para lidar com seu dinheiro (pagar contas, conferir troco, ir ao banco, etc.)?	SIM ()	NÃO ()					
15	Incontinência	O(a) Sr.(a.) perde urina sem querer?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 3 itens (1 PONTO)				
		O(a) Sr.(a.) perde fezes sem querer?	SIM ()	NÃO ()					
16	Perda de peso não intencional	Nos últimos 12 meses o(a) Sr.(a.) perdeu peso sem ter feito dieta ou mudado qualquer hábito de vida? (4,5 kg ou 5% de perda nos últimos 12 meses)	NÃO () (0 PONTO)		SIM () (1 PONTO)				
17	Condições bucais	O(a) Sr.(a.) tem problemas para mastigar devido a problemas nos seus dentes ou na sua prótese?	SIM ()	NÃO ()	() NÃO para todos os itens (0 PONTO) () SIM em 1 a 4 itens (1 PONTO)				
		O(a) Sr.(a.) tem problemas para engolir ou apresenta engasgos ao se alimentar?	SIM ()	NÃO ()					
		O(a) Sr.(a.) deixou de comer algum tipo de alimento pela falta de dentes ou problemas nos seus dentes ou na sua prótese?	SIM ()	NÃO ()					
		Sua(s) prótese(s) está(ão) lhe trazendo desconforto?	SIM ()	NÃO ()					
CLASSIFICAÇÃO		() SAÚDAVEL - 0 a 5 pontos		() PRÉ-FRÁGIL - 6 a 10 pontos		() FRÁGIL - ≥ 11 pontos		Total	
DATA:		Nome e Assinatura do Profissional:							

Avaliação Geriátrica Compacta de 10 minutos (AGC-10):

AGC-10 (ou *10-minute Targeted Geriatric Assessment* [10-TaGA]) avalia 10 itens de saúde, incluindo suporte social, uso recente do sistema de saúde, número de quedas no último ano, número de medicamentos em uso regular, funcionalidade para atividades básicas de vida diária, cognição, autoavaliação da saúde, sintomas depressivos, estado nutricional e velocidade da marcha. O instrumento utiliza um método prático que combina testes de performance e informações autorrelatadas. O tempo de aplicação da AGC-10 é de cerca de 10 minutos. Cada parâmetro é pontuado como normal (0,0 pontos), alteração leve (0,5 pontos) ou alteração grave (1,0 ponto). A pontuação final é calculada pela soma total de pontos dividida pelo número de itens avaliados, o que resulta em um escore global que varia de 0,0 (nenhum déficit) a 1,0 (déficit total). Estudos realizados no Brasil em ambiente ambulatorial especializado e de cuidados agudos demonstraram que o escore global da AGC-10 é forte preditor de perda funcional, hospitalização e morte em até três anos de seguimento (Aliberti, 2018; Aliberti, 2019; Saraiva, 2020).

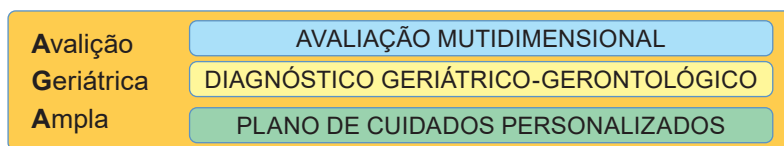
Figura 5: AGC-10

Suporte Social	Mora com quem?	Sozinho [pergunta abaixo]	☐ Familiar ou ☐ cuidador [0,0]	Institucionalizado [0,5]	Pontos
Se ficasse de cama, com que frequência contaria com alguém para ajuda-lo(a)? (apenas para quem mora sozinho)					_____
☐ Sempre ou ☐ quase sempre [0,5] ☐ Às vezes, ☐ raramente ou ☐ nunca [1,0]					_____
Uso Sistema de Saúde	Nenhum [0,0]	☐ Visita ao Pronto Atendimento apenas [0,5]	☐ Internação Hospitalar [1,0]		_____
Nos últimos seis meses					_____
Quedas	Sem quedas [0,0]	1 queda [0,5]	≥ 2 quedas [1,0]		_____
No último ano					_____
Medicações	< 5 [0,0]	5 – 9 [0,5]	≥ 10 N. med. [1,0]		_____
Número em uso contínuo					_____
Funcionalidade	Avaliação baseada no índice de Katz (atividades básicas de vida diária)			NÃO SIM	_____
Tomar banho	Realiza sem assistência ou recebe ajuda apenas para uma parte do corpo.			1 0	_____
Vestir-se	Pega as roupas e se veste completamente sem ajuda, exceto para amarrar sapatos.			1 0	_____
Vaso sanitário	Vai ao banheiro, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda (pode usar dispositivo de apoio e, urinol à noite).			1 0	_____
Transferência	Deita-se e sai da cama, senta-se e levanta-se da cadeira sem ajuda (pode usar dispositivos de apoio).			1 0	_____
Continência	Controla inteiramente a micção e evacuação.			1 0	_____
Alimentação	Alimenta-se sem ajuda ou recebe assistência apenas para cortar a carne ou passar manteiga no pão.			1 0	_____
[0,0] 0 pontos [0,5] 1 – 2 pontos [1,0] ≥ 3 pontos					_____
Cognição	Avaliação baseada no 10-Point Cognitive Screener (10-CS)				_____
Orientação: ☐ dia do mês ☐ mês ☐ ano _____					_____
Aprendizado: CARRO – VASO – TIJOLO (até 3 tentativas se necessário; não pontua)					_____
Fluência (animais em 60s): ☐ 0-5 = 0 ☐ 6-8 = 1 ☐ 9-11 = 2 ☐ 12-14 = 3 ☐ ≥ 15 = 4					_____
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____					_____
9. _____ 10. _____ 11. _____ 12. _____ 13. _____ 14. _____ 15. _____ 16. _____					_____
Evocação: ☐ carro ☐ vaso ☐ tijolo _____					_____
Pontuação Bruta: _____ /10					_____
Pontuação Ajustada: _____ /10 (+2 se escolaridade = 0; +1 se escolaridade = 1-3 anos; máximo 10)					_____
[0,0] ≥ 8 pontos [0,5] 6-7 pontos [1,0] 0-5 pontos					_____
Autoavaliação	Como você considera a sua saúde geral?				_____
☐ Incapaz (se 10-CS Bruto=0)	Muito ruim [1,0]	Ruim [1,0]	Razoável [0,5]	Boa [0,0] Muito boa [0,0]	_____
Sintomas Depressivos	Avaliação baseada na Escala de Depressão Geriátrica de 4 itens			NÃO SIM	_____
☐ Incapaz (se 10-CS Bruto=0)	Você está satisfeito com a sua vida?			1 0	_____
Você abandonou muitas das suas atividades e dos seus interesses?					0 1
Você se sente feliz a maior parte do tempo?					1 0
Você prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas?					0 1
[0,0] 0 – 1 ponto [0,5] 2 pontos [1,0] 3 – 4 pontos					_____
Nutrição	Perda de Peso (≥ 4,5kg no último ano): ☐ NÃO ☐ SIM Peso último ano: _____ kg				_____
Peso atual: _____ Kg Altura: _____ m IMC: _____ kg/m² CP: _____ cm					_____
Se não for possível utilizar a balança devido à imobilidade, substitua o IMC por Circunferência da Panturrilha (CP), sendo CP < 31 cm alterada.					_____
[0,0] sem a perda de peso e IMC ≥ 22 [0,5] com a perda de peso ou IMC < 22 [1,0] com a perda de peso e IMC < 22					_____
Velocidade de Marcha	Caminhar 4,5 metros duas vezes e considerar melhor tempo.				_____
Tempo 1: _____ segundos Tempo 2: _____ segundos					_____
[0,0] ≤ 4,4s (> 1,0m/s) [0,5] 4,5 – 7,5s (0,6 – 1,0m/s) [1,0] ≥ 7,6s (< 0,6m/s) ou ☐ incapaz					_____
SOMA TOTAL					_____
ÍNDICE AGC-10					_____
(soma total dividido pelo nº de itens avaliados)					_____

Estrutura

A AGA é constituída por três elementos essenciais e indissociáveis: avaliação multidimensional da pessoa idosa, diagnóstico geriátrico-gerontológico e o plano de cuidados personalizado (Figura 6).

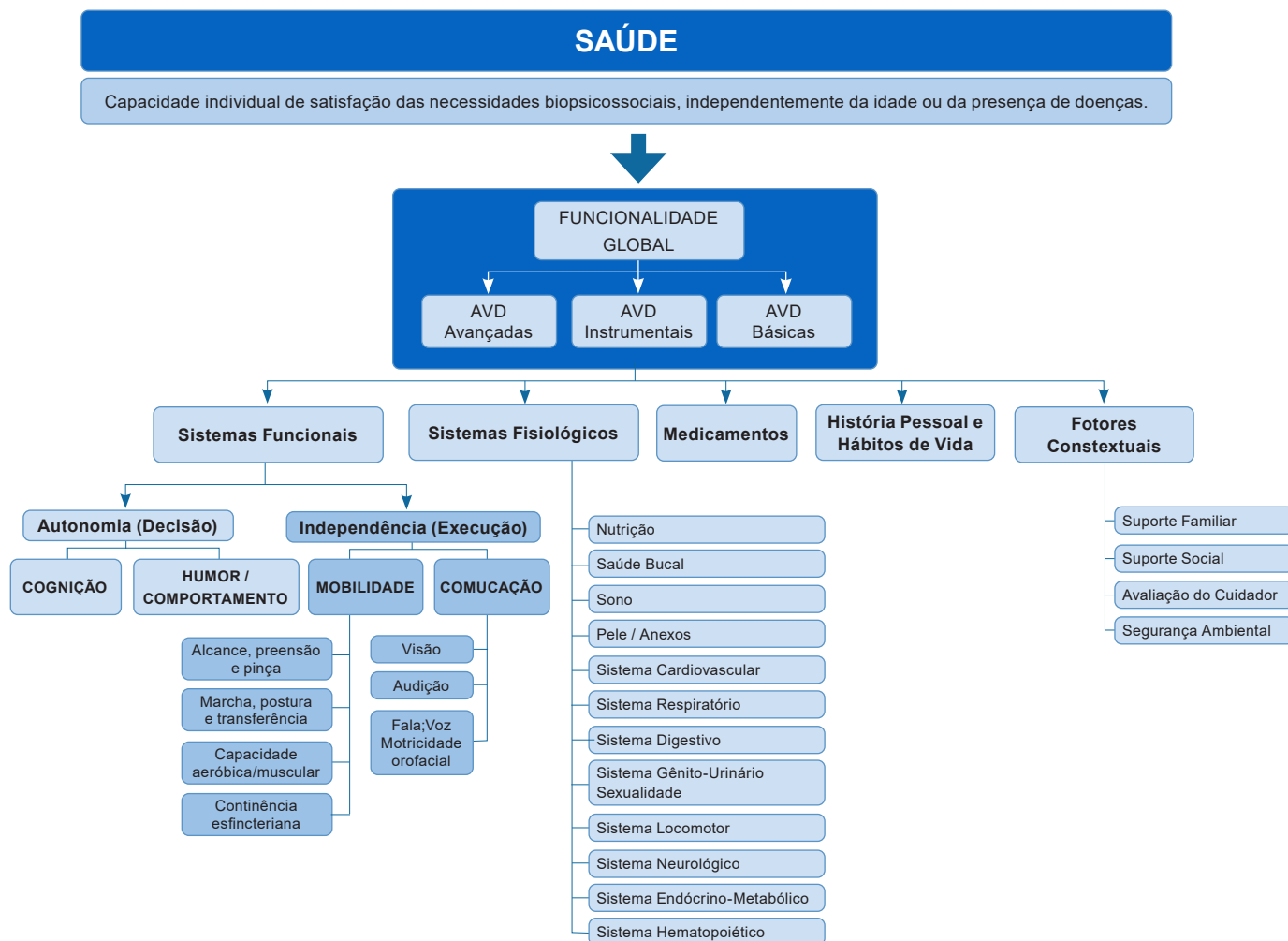
Figura 2: Estrutura da AGA



Avaliação Multidimensional da Saúde da Pessoa Idosa

A avaliação multidimensional da saúde da pessoa idosa deve incluir os principais determinantes da saúde, definida como a capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, independentemente da idade ou da presença de doenças. Assim, o conceito de saúde está centrado na sua funcionalidade global ou capacidade funcional, responsável pela realização das atividades de vida diária (AVD) avançadas (AAVD), instrumentais (AIVD) e básicas (ABVD), de forma independente e autônoma. A autonomia refere-se à capacidade individual de decisão e comando sobre suas ações, estabelecendo e seguindo suas próprias convicções. A independência refere-se à capacidade de executar algo com os próprios meios. Portanto, a autonomia ou capacidade de decisão está relacionada às funções mentais, representadas pela cognição e pelo humor e comportamento. Por sua vez, a independência ou capacidade de execução das decisões está relacionada à mobilidade (capacidade de deslocamento e de manipulação do meio) e à comunicação (capacidade de interação com o meio). Os componentes da mobilidade são o alcance, preensão e pinça, a capacidade aeróbica ou muscular, a marcha e a continência esfincteriana. Os componentes da comunicação estão relacionados à linguagem (cognição) e ao funcionamento adequado dos órgãos dos sentidos (visão e audição) e dos órgãos eferentes da comunicação, como a fala propriamente dita.

Figura 7: Dimensões da saúde da pessoa idosa



A autonomia e independência da pessoa idosa está estritamente relacionada à preservação dos sistemas funcionais (cognição, humor/comportamento, mobilidade e comunicação), que devem estar harmonicamente integrados aos sistemas fisiológicos (nutrição, saúde bucal, sono, pele e anexos, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema gênito-urinário, sistema locomotor, sistema neurológico, sistema endócrino-metabólico e sistema hematopoiético) e aos fatores contextuais, representados pelo suporte familiar, suporte social, segurança ambiental e saúde do cuidador. O uso de medicamentos e a história pessoal e hábitos de vida são também dimensões da saúde da pessoa idosa que devem fazer parte da avaliação geriátrico-gerontológica, pois contribuem diretamente nos sistemas funcionais e fisiológicos.

Cada um desses elementos deve ser avaliado diretamente, utilizando-se estratégias, escalas ou instrumentos específicos.

Funcionalidade

A funcionalidade representa a capacidade do indivíduo em ser independente na provisão de seu autocuidado (atividades básicas de vida diária, ABVD), bem como viver em comunidade de forma independente e autônoma (atividades instrumentais de vida diária, AIVD). Geralmente a avaliação da funcionalidade é realizada pelas escalas de Katz (ABVD) e Lawton (AIVD). Os quadros 1 e 2 descrevem as escalas de Katz e Lawton, respectivamente, com mais detalhes. Outro instrumento bastante difundido e validado no Brasil é o índice de Barthel. Esse instrumento é composto por 10 itens que avaliam ABVD e mobilidade; sua pontuação varia de 0 a 100 pontos, e quanto maior a pontuação, melhor a funcionalidade (Minosso et al, 2010). O Questionário de Atividades Funcionais (FAQ) de Pfeffer é outro instrumento utilizado para avaliação do grau de independência para o desempenho de dez atividades de vida diária. Avalia dez AIVD instrumentais, nas quais há o envolvimento maior das habilidades cognitivas. A pontuação final varia de 0 (independência) a 30 pontos (maior grau de dependência). Escore iguais ou superiores a cinco pontos apresentam boa sensibilidade e especificidade para a presença de declínio funcional com alteração na cognição (Sanchez et al, 2011).

Quadro 1: Escala de Lawton – Grau de Independência em Atividades Instrumentais da Vida Diária

Atividade	Grau de dependência
Tomar banho	
Não recebe ajuda ou ajuda apenas em uma parte do corpo. Recebe ajuda para lavar mais de uma parte do corpo ou não toma banho sozinho,	Independente (0) Dependente (1)
Vestir-se (inclui pegar roupas nos armários e gavetas)	
Pega as roupas e veste-se completamente, auxílio para amarrar os sapatos ou não. Recebe ajuda para pegar as roupas ou vestir-se, ou permanece parcial ou completamente sem roupa.	Independente (0) Dependente (1)
Uso do vaso sanitário (ir ao banheiro, higiene e arrumar as roupas)	
Vai ao banheiro, limpa-se e ajeita as roupas sem ajuda - permitido uso de dispositivo de marcha e “comadre/papagaio.” Recebe ajuda para ir ao banheiro, para limpar-se, ajeitar as roupas ou utilizar “comadre/ papagaio” ou não vai ao banheiro.	Independente (0) Dependente (1)
Transferência	
Deita-se ou sai da cama, senta-se ou levanta-se da cadeira sem auxílio - permitido dispositivo de marcha. Recebe ajuda para deitar-se e/ou sentar ou não sai da cama.	Independente (0) Dependente (1)
Continência	
Controla inteiramente a micção e evacuação. Episódios de incontinência ou necessita de ajuda para manter o controle da micção e evacuação, uso de cateter ou é incontinente.	Independente (0) Dependente (1)
Alimentação	
Alimenta-se sem ajuda ou recebe auxílio apenas para cortar a carne ou passar manteiga no pão. Recebe ajuda para alimentar-se ou é alimentado parcial ou completamente por cateteres ou fluidos intravenosos.	Independente (0) Dependente (1)
Interpretação: pontuação varia de 0 a 6, sendo 0 indivíduos totalmente independentes e 6 aqueles totalmente dependentes.	

Quadro 2: Escala de Katz – Grau de Independência em Atividades da Vida Diária

Atividades Instrumentais de Vida Diária
Usar o telefone
Fazer compras
Preparar refeições
Tarefas domésticas
Trabalhos manuais e pequenos reparos na casa
Lavar roupas
Meio de transporte (dirigir ou viajar sozinho de ônibus, trem, metrô e taxi)
Uso de medicamentos
Manuseio de dinheiro
Pontuação de cada item: 1 ponto se incapaz; 2 pontos quando necessita de alguma ajuda; 3 pontos se totalmente capaz.
Interpretação: o escore varia de 9 a 27 pontos, sendo 9 pontos: totalmente dependente; 10-24: parcialmente dependente; 25-27: independente.

Cognição

É a capacidade mental de compreender e resolver adequadamente os problemas do cotidiano. A cognição é um conjunto de habilidades mentais que permitem ao indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano. É responsável pela nossa capacidade de decidir e, portanto, é domínio fundamental para a manutenção da autonomia, juntamente com o humor/comportamento. Déficits cognitivos e síndromes demenciais se tornam mais frequentes com o avançar da idade, sendo comum o não reconhecimento de tais condições através da entrevista médica tradicional. Na prática clínica com idosos, é imprescindível a busca ativa de alterações cognitivas já que podem afetar diretamente a funcionalidade e a autonomia do indivíduo.

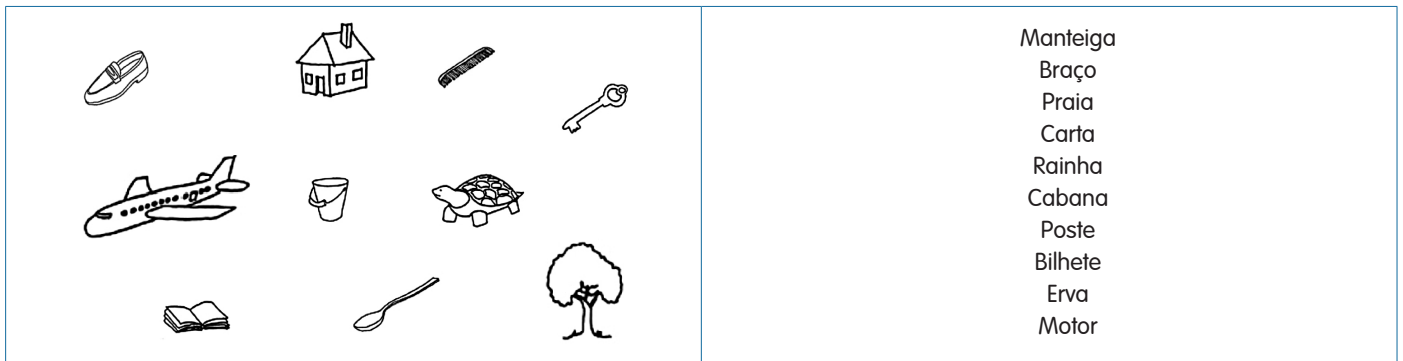
Vale ressaltar que, de forma geral, as escalas de rastreio cognitivo são afetadas pela escolaridade, sendo este um dado muito importante a ser extraído na parte inicial da AGA.

São diversos os instrumentos disponíveis para o rastreio cognitivo. O **Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)** consiste em um método amplamente conhecido e prático proposto por Folstein et al. (1975) e amplamente validado para a população brasileira. É composto por 11 itens e a pontuação máxima é de 30 pontos (ver quadro X). A **Fluência Verbal** é outro teste de rastreio cognitivo bastante utilizado na prática devido a sua rapidez (um minuto), simplicidade e eficiência para avaliação de diferentes áreas da cognição, como linguagem, memória semântica e função executiva. A **Lista de Palavras do CERAD** (Bertolucci, 1988) avalia a curva de aprendizagem do indivíduo, no qual são apresentadas dez palavras não relacionadas, lentamente (uma palavra a cada 2 segundos), solicitando que ele as repita, uma a uma. Ao final, o examinador solicita a repetição das palavras lidas ou ditas, por um tempo máximo de 90 segundos (evocação), em qualquer ordem. O procedimento é repetido com as palavras em outra ordem, mais duas vezes (memória da lista de palavras). Portanto, a lista de palavras é apresentada três vezes consecutivas e em cada etapa é solicitado que o paciente evoque as palavras de que se lembrar por um período máximo de 90 segundos. Ao final das três etapas, o examinador insere uma tarefa distratora, que pode ser outro teste cognitivo. Após algum tempo (5 minutos), é feita a evocação da lista de palavras por um período máximo de 90 segundos (evocação da lista de palavras) (Figura 8). O teste de **Reconhecimento de 10 Figuras** segue a mesma lógica: são apresentadas 10 figuras padronizadas e solicita-se que o paciente reconheça e nomeie corretamente. Em seguida, o examinador esconde a folha com as dez figuras e pergunta quais eram as figuras. O procedimento é repetido mais duas vezes. Em seguida, o examinador inclui um distrator, que pode ser outro teste cognitivo, e, após 5 minutos, solicita que o paciente repita as figuras mostradas. Finalmente, o examinador apresenta uma lista de 20 figuras, incluindo as 10 figuras originais e pergunta quais figuras já tinham sido mostradas (Nitrini R., 1994; Nitrini R., Caramelli P., Herrera E., 2004) (Figura 8). O **Teste do Relógio** também pode ser utilizado, pela sua simplicidade e rapidez na aplicação. Além disso, a sua interpretação é visual e funciona como “termômetro cognitivo” para os familiares do paciente. Consiste em solicitar ao paciente que desenhe os números do relógio, marcando determinada hora (11:10h), sem mencionar a necessidade de ponteiros. O círculo pode ou não ser oferecido previamente (10 a 12 cm). O O quadro 3 abaixo sintetiza o resultado dos testes.

Quadro 3: Testes cognitivos mais utilizados na prática clínica

Instrumentos Específicos												
Mini-Exame do Estado Mental	OT	OE	3 pal	AC	Ev	Nom	Rep	3 est	Ler/Exe	Escr	Pent	
	5	5	3	5	3	2	1	3	1	1	1	
Lista de Palavras do CERAD	1ª tent		2ª tent		3ª tent		Evoc 5 min		Reconh			
	4		6		7/8		3/4		8			
Reconhecimento de Figuras	Perc/Nom		Mem Incid		Mem Imed 1		Mem Imed 2		Evoc 5 min		Reconhec	
	9/9		5		6		6		5		8	
MoCA-Brasil	Visuo/Exec		Nomeaç		Atenção			Ling		Abst	Evoc Tar	Orientação
	5		3		2	1		1	2	1	2	5
10-CS	Orientação			Aprendizado		Fluência Verbal Semântica			Evocação			
	3			3		4			3			
Fluência Verbal	Analfabeto ou baixa escolaridade: nove ou mais animais ou frutas; Oito anos ou mais de escolaridade: 13 ou mais animais ou frutas.											
Teste do Relógio	Avalia-se a distribuição espacial dos números do relógio e a marcação das horas, utilizando-se os ponteiros.											

Figura 8: Lista de figuras e palavras utilizadas



Mais recentemente, o **Montreal Cognitive Assessment (MoCA)** tem sido proposto para o rastreio cognitivo global de idosos por ampliar o número de domínios avaliados, sobretudo funções executivas e atenção, e pela capacidade de detectar comprometimento cognitivo leve. Entretanto, apresenta limitações para pacientes de baixa escolaridade devido à falta de notas de corte bem definidas. Para tal população, pode ser aplicada a versão simplificada do MoCA, o Montreal Cognitive Assessment - Basic (MoCA-B), que também permite a monitorização evolutiva de pacientes com alterações cognitivas leves (Figura 9).

Figura 9: MoCA Brasil

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) Nome: _____ Data de nascimento: ____/____/____
Versão Experimental Brasileira Escolaridade: _____ Data de avaliação: ____/____/____
 Sexo: _____ Idade: _____

VISUOESPACIAL / EXECUTIVA		Pontos	
	Copiar o cubo Desenhar um RELÓGIO (onze horas e dez minutos) (3 pontos)	[] [] [] Contorno Números Ponteiros	____/5
NOMEAÇÃO 		[] [] []	____/3
MEMÓRIA Leia a lista de palavras, O sujeito deve repeti-la, faça duas tentativas. Evocar após 5 minutos.	Rosto Veludo Igreja Margarida Vermelho 1ª tentativa [] [] [] [] [] 2ª tentativa [] [] [] [] []	Sem Pontuação	
ATENÇÃO Leia a sequência de números (1 número por segundo). O sujeito deve repetir a sequência em ordem direta [] 2 1 8 5 4 O sujeito deve repetir a sequência em ordem indireta [] 7 4 2			____/2
Leia a série de letras. O sujeito deve bater com a mão (na mesa) cada vez que ouvir a letra "A". Não se atribuem pontos se ≥ 2 erros. [] F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B			____/1
Subtração de 7 começando pelo 100 [] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65 4 ou 5 subtrações corretas: 3 pontos; 2 ou 3 corretas 2 pontos; 1 correta 1 ponto; 0 correta 0 ponto			____/3
LINGUAGEM Repetir: Eu somente sei que é João quem será ajudado hoje. [] O gato sempre se esconde embaixo do Sofá quando o cachorro está na sala. []			____/2
Fluência verbal: dizer o maior número possível de palavras que comecem pela letra F (1 minuto). [] _____ (N ≥ 11 palavras)			____/1
ABSTRAÇÃO Semelhança p. ex. entre banana e laranja = fruta [] trem - bicicleta [] relógio - régua			____/2
EVOCAÇÃO TARDIA Deve recordar as palavras SEM PISTAS Rosto Veludo Igreja Margarida Vermelho [] [] [] [] []		Pontuação apenas para evocação SEM PISTAS	____/5
OPCIONAL Pista de categoria [] [] [] [] [] Pista de múltipla escolha [] [] [] [] []			
ORIENTAÇÃO [] Dia do mês [] Mês [] Ano [] Dia da semana [] Lugar [] Cidade			____/6
© Z. Nasreddine MD www.mocatest.org Versão experimental Brasileira: Ana Luisa Rosas Sarmento Paulo Henrique Ferreira Bertolucci - José Roberto Wajman (UNIFESP-SP 2007)		TOTAL Adicionar 1 pt se ≤ 12 anos de escolaridade ____/30	

No Brasil, foi desenvolvido e validado o 10-point Cognitive Screening (10-CS) que mescla itens do MEEM (orientação temporal e evocação tardia) com a fluência verbal (Quadro). Esse instrumento, apresentou acurácia superior ao MEEM na detecção de comprometimento cognitivo em estudo prévio. Além disso, pode ser administrado em apenas dois minutos sem necessidade de uso de lápis, caneta ou papel (Quadro 4).

Quadro 4: Point Cognitive Screener (10-CS)

Orientação	Pontuação
Em que ano estamos?	Correto: 1 ponto Errado: 0
Em que mês estamos?	Correto: 1 ponto Errado: 0
Que dia do mês é hoje?	Correto: 1 ponto Errado: 0
Aprendizado	Não pontua
Repetir o nome de 3 objetos e memorizar (até 3 tentativas se necessário): Óculos, caneta e martelo	
Fluência verbal semântica	
Nomes de animais em 1 minuto	0 a 5 animais: 0 ponto 6 a 8 animais: 1 ponto 9 a 11 animais: 2 pontos 12 a 14 animais: 3 pontos ≥ 15 animais: 4 pontos
Evocação (nome dos 3 objetos)	
Óculos, caneta e martelo	1 ponto para cada acerto (total 3 pontos)
Ajuste para escolaridade (10-CS – Edu): máximo de 10 pontos Sem escolarização formal: +2 pontos 1 a 3 anos: +1 ponto	
Interpretação: ≥ 8 pontos: normal 6 a 7 pontos: comprometimento cognitivo possível 0 - 5 pontos: comprometimento cognitivo provável	

Os testes de rastreio cognitivo apresentam diferenças quanto à sua capacidade de avaliação das diversas funções cognitivas: memória e aprendizado, função executiva, linguagem e funções perceptomotoras (habilidades visuoespaciais, gnosia, praxia). Devem, portanto, ser complementares, dependendo da suspeita clínica obtida na história do paciente e na avaliação subjetiva da cognição. A aplicação e interpretação correta dos testes é fundamental para o preenchimento dos critérios diagnósticos exigidos para transtorno neurocognitivo leve e maior. Deve-se ressaltar que outros transtornos neuropsiquiátricos podem causar declínio cognitivo e comprometer o desempenho nos testes, como a depressão, delirium e os transtornos mentais primários, como a esquizofrenia.

Humor/Comportamento

O humor é outra unção indispensável para a preservação da autonomia do indivíduo, sendo essencial para a realização das atividades de vida diária. É a motivação necessária para a realização das atividades e/ou participação social. Inclui também o comportamento do indivíduo, que é afetado pelas outras funções mentais, como a sensopercepção, o pensamento e o nível de consciência.

Alterações do humor são muito frequentes na população idosa, especialmente a depressão, e associam-se a pior qualidade de vida, perda funcional e prejuízo cognitivo. A apresentação do transtorno depressivo em idosos costuma ser atípica devido à alta prevalência de sintomas somáticos, o que dificulta o diagnóstico e início precoce do tratamento. Os instrumentos mais utilizados para rastreamento de depressão são a Escala de Depressão Geriátrica de 15 e 5 itens (Quadro 5) e o Questionário sobre Saúde do Paciente (PHQ-9: *Patient Health* Questionnaire-9). O PHQ-9 é um instrumento de rápida aplicação, contendo nove questões, cuja pontuação varia de 0 a 30 pontos (Quadro 6). Foi sugerido o ponto de corte ≥ 9, como de máxima sensibilidade e especificidade, no estudo de validação do instrumento em adultos no Brasil (Santos et al, 2013). Por sua vez, a Escala Cornell de Depressão na Demência (ECDD) é considerada um instrumento de fácil e rápida aplicação, que foi validada, originariamente, com o objetivo de quantificar os sintomas depressivos e para o monitoramento da resposta terapêutica nos indivíduos com demência e depressão. Apesar de controverso, a escala pode ser utilizada para o diagnóstico de depressão nos indivíduos com ou sem demência. Os pontos de corte recomendados são: < 6 pontos (ausência de sintomatologia depressiva significativa), 6 a 9 pontos (diagnóstico duvidoso, dependendo do contexto clínico), 10 a 17 pontos (episódio depressivo maior provável) e ≥ 18 pontos (episódio depressivo maior definitivo) (Quadro 7). É importante destacar que todas as escalas apresentadas são instrumentos de rastreio e o diagnóstico formal de depressão deve basear-se nos critérios diagnósticos da 5ª edição do *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM-5).

Quadro 5: Escala Geriátrica de Depressão

Escala Geriátrica de Depressão (GDS-15 e GDS-5)				
Para cada questão, escolha a opção que mais se assemelha ao que você está sentindo nas últimas semanas			Sim	Não
GDS-15	GDS-5	Você está basicamente satisfeito com sua vida?	0	1
		Você se aborrece com frequência?	1	0
		Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias?	1	0
		Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas?	1	0
		Você sente que sua situação não tem saída?	1	0
	Pontuação na GDS-5 (Escore ≥ 2 pontos sugere o diagnóstico de depressão)			
	Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer?		1	0
	Você acha que sua situação é sem esperanças?		1	0
	Você acha maravilhoso estar vivo?		0	1
	Você sente que sua vida está vazia?		1	0
	Você sente que a maioria das pessoas está melhor que você?		1	0
	Você se sente com mais problemas de memória do que a maioria?		1	0
	Você deixou muitos de seus interesses e atividades?		1	0
	Você se sente de bom humor a maior parte do tempo?		0	1
	Você se sente cheio de energia?		0	1
	Você se sente feliz a maior parte do tempo?		0	1
Pontuação na GDS-15 (Escore >5 pontos sugere o diagnóstico de depressão)				

Quadro 6: Versão em português do Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

Agora vamos falar sobre como o(a) sr.(a) tem se sentido nas últimas duas semanas
1) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) teve pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
2) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) se sentiu para baixo, deprimido(a) ou sem perspectiva? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
3) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) teve dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo ou dormiu mais do que de costume? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
4) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) se sentiu cansado(a) ou com pouca energia? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
5) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) teve falta de apetite ou comeu demais? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
6) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) se sentiu mal consigo mesmo(a) ou achou que é um fracasso ou que decepcionou sua família ou a você mesmo(a)? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias
7) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) teve dificuldade para se concentrar nas coisas (como ler o jornal ou ver televisão)? (0) Nenhum dia (1) Menos de uma semana (2) Uma semana ou mais (3) Quase todos os dias

Agora vamos falar sobre como o(a) sr.(a) tem se sentido nas últimas duas semanas

8) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) teve lentidão para se movimentar ou falar (a ponto das outras pessoas perceberem), ou ao contrário, esteve tão agitado(a) que você ficava andando de um lado para o outro mais do que de costume?

- (0) Nenhum dia
- (1) Menos de uma semana
- (2) Uma semana ou mais
- (3) Quase todos os dias

9) Nas últimas duas semanas, quantos dias o(a) sr.(a) pensou em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto(a)?

- (0) Nenhum dia
- (1) Menos de uma semana
- (2) Uma semana ou mais
- (3) Quase todos os dias

10) Considerando as últimas duas semanas, os sintomas anteriores lhe causaram algum tipo de dificuldade para trabalhar ou estudar ou tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as pessoas?

- (0) Nenhuma dificuldade
- (1) Pouca dificuldade
- (2) Muita dificuldade
- (3) Extrema dificuldade

Quadro 7: Escala de Cornell de Depressão na Demência

Escala de Cornell de Depressão na Demencia (ECDD)									
Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD)									
Alexopoulos SG et al (Biol Psyc hiatry.1988): Carthey-Goulart MT et al (Arq Neuropsiquiatr, 2007): Hancock P et ai. (Int J Psychiatry Clin Pract, 2014).									
A avaliação foi feita em:			Ambulatório	Hospital	ILPI	Pontuação			
A avaliação é feita preferencialmente com o cuidador e, rapidamente, com o paciente. A pontuação deve ser baseada em sintomas e sinais ocorridos durante a semana anterior à entrevista. Nenhuma pontuação deve ser dada se o sintoma for resultado de uma incapacidade física ou de uma doença.						Impossibi- lidade de avaliação a	Ausente 0	Leve ou Intermetimente 1	Grave 2
A	A Sinais relacio- nados ao humor	1. Ansiedade (expressão ansiosa, ruminações, preocupações)							
		2. Tristeza (expressão triste, voz triste, choroso)							
		3. Falta de reações a eventos prazerosos							
		4. Irritabilidade (facilmente aborrecido temperamento explosivo)							
B	Distúrbios de comportamento	5. Agitação (inquietação, agitação constante das mãos, puxa o cabelo)							
		6. Retardo (movimentos lentos, fala lenta, reação lenta)							
		7. Queixas físicas múltiplas (escore 0 se forem somente sintomas gas- trointestinais)							
		8. Perda do interesse (menor envolvimento em atividades usuais, pontue apenas se a alteração ocorrer agudamente. isto é, em menos de um mês) C Sinais Físicos							
C	Sinais Físicos	9. Perda do apetite (come menos que o usual)							
		10. Perda de peso (marque 2 pontos se for maior que 2,27 (5 libras) em um mês)							
		11. Falta de energia (facilmente fatigado, incapaz de sustentar atividades; marque pontos apenas se a alteração ocorrer repetidamente, isto é, em menos de um mês). D Funções Cíclicas							
D	Funções Cíclicas	12. Variação diurna de humor (os sintomas são piores pela manhã)							
		13. Dificuldade para dormir (está indo dormir mais tarde que o usual para este indivíduo)							
		14. Desperta muitas vezes durante o sono							
		15. Desperta precoce (mais cedo que o usual para este indivíduo) E Dis- túrbio de Ideação							
E	Distúrbio de Ideação	16. Suicídio (sente que a vida não vale a pena, tem desejos suicidas ou faz tentativas de suicídio)							
		17. Baixa auto-estima (culpa-se, deprecia-se, sentimentos de fracasso)							
		18. Pessimismo (antecipa o pior)							
		19. Delírios congruentes com o humor (delírios de pobreza, doença ou perda)							
						Escore total: /38			

Existem várias escalas de avaliação das alterações comportamentais na pessoa idosa, particularmente na presença de demência, condição altamente associada à presença de sintomas comportamentais e psicológicos. O Inventário Neuropsiquiátrico (NPI) é um instrumento válido e confiável, desenvolvido para avaliar doze distúrbios neuropsiquiátricos comumente observados na demência, como alucinação, delírio, apatia/indiferença, disforia, agitação ou agressividade, ansiedade, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, euforia/elação, alterações alimentares e comportamento noturno. Além da avaliação qualitativa, o NPI fornece uma avaliação quantitativa do sofrimento experimentado pelos cuidadores em relação aos domínios avaliados no instrumento (Camozzato et al, 2008).

Mobilidade

É a capacidade individual de deslocamento e de manipulação do meio. Por sua vez, a mobilidade depende de quatro subsistemas funcionais: a capacidade aeróbica e muscular (massa e função), o alcance/preensão/pinça (membros superiores) e a marcha, postura e transferência. A continência esfinteriana é também considerada um subdomínio da mobilidade, pois a sua ausência (incontinência esfinteriana) é capaz de interferir na mobilidade e restringir a participação social do indivíduo.

Alcance, preensão e pinça

A manipulação do meio é uma habilidade fundamental na mobilidade e depende diretamente dos membros superiores (ombros e mão). O ombro é a articulação mais flexível do corpo, graças a sua constituição complexa. A síndrome do “ombro doloroso” é uma importante causa de dor, limitação funcional e dependência física no idoso. Tem como causas principais as artrites, tendinites e bursites. A lesão do manguito rotador ou síndrome do impacto é a principal causa de dor e incapacidade no ombro, especialmente quando ocorre sua ruptura, parcial ou total. Sua lesão caracteriza-se pela presença de dor e dificuldade de elevação e sustentação do braço afetado, em tarefas como pentear o cabelo, pendurar roupas no varal, tocar as costas, arremessar objetos, vestir-se ou despir-se, segurar objetos acima da cabeça, etc. As mãos, por sua vez, são estruturas extremamente complexas e funcionalmente decisivas para a independência do indivíduo. A presença do dedo oponente, o polegar, permite o “movimento de pinça”, fundamental para a evolução da espécie humana. As mãos são frequentemente acometidas nas doenças reumatológicas e podem trazer limitações importantes para a paciente, como a osteoartrite, artrite reumatóide, o dedo em “gatilho” e a síndrome do túnel do carpo.

Capacidade aeróbia e muscular

A capacidade aeróbia pode ser definida como a capacidade do organismo de absorver, transportar e utilizar o oxigênio para a produção de energia, particularmente durante a atividade física. Está relacionado ao funcionamento adequado do pulmão, coração, hemoglobina e músculo esquelético. A presença de dispnéia de esforço ou intolerância ao exercício é o sintoma mais característico da presença de redução da capacidade aeróbica, que pode estar presente na insuficiência respiratória ou cardíaca, anemia e na presença de sarcopenia ou dinapenia. A sarcopenia é uma doença caracterizada pela acelerada perda de massa e força muscular com redução do desempenho físico nos indivíduos. Essa doença é mais comum em pessoas com mais de 60 anos, o que pode gerar dificuldade para realizar atividades rotineiras, como caminhar e subir escadas. Na presença de suspeita clínica de sarcopenia, o diagnóstico deve ser confirmado pela avaliação da força muscular, através da medida da Força de Preensão Palmar (FPP) ou Teste do Sentar e Levantar da Cadeira (5 movimentos). Os escores utilizados para a presença de fraqueza muscular são: FPP com dinamômetro (homens < 27kg; mulheres < 16kg) e teste do sentar e levantar com duração superior a 15 segundos. A gravidade da sarcopenia é avaliada pelo Short Physical Performance Battery (SPPB), o Timed get-up and go test ou o teste de caminhada de 400 metros. A redução da velocidade da marcha é definida quando o desempenho no teste de caminhada for $\leq 0,8\text{m/s}$, pontuação no SPPB ≥ 8 pontos, TUG ≥ 20 segundos e teste de caminhada-400m ≥ 6 minutos ou não for possível de ser completado (SBGG, 2022).

Equilíbrio e marcha

Estima-se que mais de um terço dos indivíduos com 65 anos ou mais apresentem ao menos uma queda ao ano, as quais constituem importante causa de imobilidade e morbimortalidade. Os testes descritos a seguir são os mais comumente utilizados para avaliar o equilíbrio, mobilidade e marcha dos idosos, assim como estimar o risco de quedas:

Quadro 8:

- **Teste cronometrado do levantar e andar (*Timed get-up and go test*):** solicita-se que o paciente se levante da cadeira (com encosto, mas sem apoio para os braços), caminhe 3 metros, gire, volte para o mesmo local e sente-se novamente. Esse teste avalia equilíbrio, marcha e capacidade de transferência. Interpretação: ≤ 10 segundos, independente; 11-20 segundos, independente em tarefas básicas e baixo risco de quedas; ≥ 20 segundos, dependente em várias atividades de vida diária e mobilidade, alto risco de quedas. Para a prática clínica, costuma-se considerar o teste alterado quando se obtém tempo > 14 segundos.
- **Escala de Equilíbrio e Marcha de Tinetti:** as orientações são similares ao teste cronometrado do levantar e andar, porém, ao administrar essa escala, o examinador avalia a performance do paciente em relação ao equilíbrio e marcha por meio de um escore padrão elaborado para cada movimento do teste. A pontuação nesse instrumento tem forte correlação com o risco de quedas em idosos.
- **Short Physical Performance Battery (SPPB):** uma bateria composta por três testes (velocidade de marcha, levantar da cadeira e equilíbrio estático) que avaliam performance de membros inferiores. A velocidade de marcha corresponde ao tempo que o paciente leva para caminhar quatro metros; são realizadas duas tentativas e considera-se o melhor resultado. O teste de levantar da cadeira consiste em cronometrar o tempo que o indivíduo leva para levantar 5 vezes da cadeira, o mais rápido possível, sem o apoio dos braços. Para a avaliação do equilíbrio solicita-se que o paciente permaneça estático em três posições sequenciais (pés paralelos, semi-tandem e tandem). Durante cada posição atribui-se uma nota de acordo com o equilíbrio do indivíduo. Cada teste varia de 0 a 4 pontos e a nota final na bateria corresponde a soma total, que varia de 0 a 12 pontos. Indivíduos com níveis de escore mais elevado (10-12 pontos) apresentam melhor prognóstico para risco de quedas, perda funcional, hospitalização e morte (Quadro 9).

Quadro 8: Instrumentos Específicos para Avaliação da Marcha e Capacidade Aeróbica/Muscular

		Escore	Comentários
Força de Preensão Palmar com dinamômetro			
Teste do Sentar e Levantar da Cadeira (5 movimentos)			
Short Physical Performance Battery (SPPB)	Testes de Equilíbrio		
	Velocidade da Marcha		
	Levantar e Sentar da Cadeira (5x)		
	Escore total		
Timed get-up and go test			
Escala de Equilíbrio e Marcha de Tinetti			
Teste de Caminhadas de 400 metros			

Quadro 9: SPPB

Short Physical Performance Battery (SPPB)			
		Pontuação	Comentários
Equilíbrio	Pés Juntos: 0 ou 1		
	Pés Semi-Tandem: 0 ou 1		
	Pés Tandem: 0 a 2		
Velocidade da Marcha 4m	≥ 8,70 seg: 1 ponto		
	6,21 a 8,70 seg: 2 pontos		
	4,82 a 6,20seg: 3 pontos		
	< 4,82 seg: 4 pontos		
Teste de Levantar-se da Cadeira	≥ 16,7 seg: 1 pts		
	13,70 a 16,69seg: 2 pts		
	11,20 a 13,69seg: 3 pts		
	≤ 11,19 seg: 4 pts		
TOTAL			

Continência esfincteriana

A continência urinária e fecal deve ser investigada em todo idoso. A presença de incontinência urinária (IU) é frequentemente negligenciada pelo idoso e pela equipe de saúde, pois, na maioria das vezes, ambos a consideram como algo “normal da idade”. Na avaliação do idoso, deve-se estar atento ao odor de uréia típico da IU ou a qualquer tipo de proteção, como absorventes, panos, etc. Além disso, deve-se questionar sobre a presença de perda involuntária de urina várias vezes ao longo da consulta, de forma explícita (ver capítulo de incontinência urinária).

Comunicação

É a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, ideias e sentimentos. Depende de três subsistemas funcionais: visão, audição e produção/motricidade orofacial. Este último é representado pela voz, fala e mastigação/deglutição.

As habilidades comunicativas compreendem quatro áreas distintas: linguagem, audição, motricidade oral e a fala e voz. Devem ser avaliados durante a entrevista do paciente (avaliação qualitativa) (ver capítulo de incapacidade comunicativa).

Cerca de um quinto da população com mais de 65 anos apresenta problemas de comunicação. As habilidades comunicativas compreendem três áreas distintas: linguagem, audição e produção/motricidade oral. A visão pode ser incluída como a quarta função comunicativa, atuando como função compensatória, na ausência das outras habilidades da comunicação oral-verbal. O rastreamento da função auditiva deve ser feito anualmente entre os idosos, utilizando-se o teste do sussurro e a otoscopia para a detecção de rolha de cerúmen (Lin 2011; Pacala, 2012).

O teste do sussurro avalia a compreensão de sons de baixa intensidade (30 dB) e alta frequência. É um teste simples, rápido e não exige nenhum instrumental específico. O examinador deve permanecer de pé, fora do alcance do campo visual do paciente, para evitar a leitura labial, a uma distância equivalente ao comprimento do braço do paciente estendido (60 cm). O examinador sussura, enquanto gentilmente comprime e massageia o tragus da orelha contralateral. A obstrução do conduto auditivo, isoladamente, é incapaz de mascarar a audição do ouvido não testado. Após uma expiração completa, o examinador sussura um conjunto de três letras/ números (“5, B, 6”), selecionados aleatoriamente. Antes do teste, o paciente deverá ter compreendido o comando, utilizando-se a voz alta e um número simples como “99”. Cada ouvido é testado individualmente e com combinações diferentes. O teste é considerado positivo caso o paciente não consiga repetir corretamente o conjunto de três letras/números. Caso positivo, o paciente deverá ser submetido à audiometria, exceto se não concordar com o uso de prótese auditiva.

A fala e a voz devem ser avaliadas rotineiramente, observando-se a respiração (capacidade, controle e coordenação da produção sonora), a fonação (intensidade e qualidade vocal), a ressonância (grau de nasalidade), a articulação (precisão articulatória e fonatória e coordenação motora) e a prosódia (ritmo

e velocidade da fala espontânea).

A triagem da acuidade visual deve ser feita em todo idoso, utilizando-se os seguintes instrumentos (Eekhof, 2000):

- Avaliação da capacidade de reconhecimento de faces a uma distância de 4 metros, em uso de lentes corretivas, caso necessário: a incapacidade de reconhecimento confirma a presença de déficit visual e a necessidade de avaliação oftalmológica específica;
- Teste de *Snellen* a 5 metros, em uso de lentes corretivas, caso necessário: pergunte se as hastes do “E” estão viradas para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda. A presença de visão $< 0,3$ ($< 20/60$) confirma a presença de déficit visual e a necessidade de avaliação oftalmológica específica;
- Leitura de jornal ou revista a 25 cm, em uso de lentes corretivas, caso necessário: a dificuldade para leitura confirma a presença de déficit visual e a necessidade de avaliação oftalmológica específica.

Sistemas fisiológicos

Nutrição

O estado nutricional de um indivíduo depende não só da capacidade de ingerir alimentos, mas também do funcionamento de seu aparelho digestório, cognição, status funcional, perda de peso recente e suporte social para preparar ou adquirir alimentos. A Mini Avaliação Nutricional (MAN) investiga todas essas informações, sendo o instrumento mais utilizado para abordar esse domínio nos pacientes idosos. O formato reduzido (Quadro 10) dessa avaliação composto por seis perguntas de triagem possui ampla validação na literatura, sendo uma opção mais rápida e prática na atenção de saúde aos idosos.

Quadro 10: Mini Avaliação Nutricional (MAN) – Formato Reduzido

Triagem
A. O consumo de alimentos diminuiu nos últimos 3 meses devido a perda de apetite, problemas digestivos, dificuldades para mastigar ou deglutir?
0. Diminuição grave
1. Diminuição moderada
2. Não houve diminuição
B. Perda de peso nos últimos 2 meses
0. Superior a 3 kg
1. Não sabe informar
2. Entre 1 e 3kg
3. Não perdeu peso
C. Mobilidade
0. Restrito ao leito ou à cadeira de rodas
1. Deambula, mas é incapaz de sair de casa sem ajuda
2. Deambula normalmente e é capaz de sair de casa sem ajuda
D. Teve algum estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses?
0. Sim
2. Não
E. Problemas neuropsicológicos
0. Tem demência e/ou depressão grave
1. Demência leve
2. Sem problemas
F. Índice de massa corporal (IMC) [peso (kg)/altura (m) ²]
0. IMC < 19
1. $19 \leq \text{IMC} < 21$
2. $21 \leq \text{IMC} < 23$
3. IMC ≥ 23
Subtotal da triagem = 14
Interpretação: 11 pontos ou menos: risco de desnutrição; 12 ou mais pontos: normal – sem risco de desnutrição

Sono

O sono pode ser definido como um estado comportamental ativo, reversível e temporário caracterizado pela redução do nível de consciência. Cerca de 1/3 de nossas vidas são dedicadas ao sono, durante o qual ocorrem vários fenômenos fisiológicos fundamentais para a regulação dos sistemas homeostáticos. Didaticamente, o sono é dividido em duas fases: sono Não-REM e sono REM (sono paradoxal ou dos movimentos rápidos dos olhos). O sono Não-REM é subdividido em três estágios (N_1 , N_2 e N_3), caracterizado pelo aprofundamento progressivo do sono e maior relaxamento muscular, associadas a padrões elétricos específicos de cada fase. A fase N_3 é a fase mais profunda (ondas lentas e sincronização neuronal), na qual ocorre maior grau de repouso muscular e restauração física. Diversos sistemas neurais estão envolvidos no controle do ciclo sono-vigília, como o Sistema Reticular Ativador Ascendente Ampliado (circuitaria indutora da vigília) e o Núcleo Ventrolateral Pré-Óptico (circuitaria indutora do sono), através de diversos neurotransmissores, como a acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, histamina orexina ou hipocretina, adenosina e melatonina. O ciclo sono-vigília sofre diversas modificações com o envelhecimento, como a menor capacidade de aprofundamento do sono (redução na fase N_3) e, consequentemente, maior superficialização do sono, maior número de

despertares noturnos e redução da duração total do sono e eficiência do sono. Outro fenômeno descrito é o “avanço de fase”, no qual o idoso tende a dormir mais cedo e, consequentemente, despertar precoce, mesmo na ausência de redução significativa da duração total de sono. Além das mudanças fisiológicas, o idoso apresenta maior prevalência de transtornos do sono vigília, como o Transtorno da Insônia, Transtorno do Ritmo Circadiano (avanço de fase), Apneia/Hipopneia Obstrutiva do Sono e Apneias Centrais, parassonias (Transtorno Comportamental do Sono REM), Síndrome das Pernas Inquietas e Movimento Periódico dos Membros. Estima-se que os transtornos do sono-vigília estão presentes em mais de 50% da população idosa e devem ser investigados rotineiramente na consulta geriátrico-gerontológica. Tais transtornos estão associados a maior morbimortalidade cardiovascular, hipertensão arterial, obesidade, depressão, fadiga, etc, e, mais recentemente, a alterações da memória e transtornos neurocognitivos. Portanto, o reconhecimento dos transtornos do sono-vigília deve ser feito rotineiramente na avaliação multidimensional da pessoa idosa, além da avaliação do uso de fármacos com ação hipnótica, como os benzodiazepínicos e fármacos do grupo Z, considerados medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. O quadro 11 apresenta uma estratégia para avaliação dos transtornos do sono no idoso e o quadro 12 mostra os principais transtornos do sono-vigília no idoso e suas principais características clínicas.

Quadro 11: Rastreamento dos transtornos do sono-vigília no idoso

Rastreamento dos Transtornos de Sono-Vigília no Idoso					
Horários do sono noturno	Início (hora de deitar para dormir):				
	Término:				
	Duração total:				
	Eficiência do sono (tempo real de sono: tempo dormido/tempo na cama):				
	Número e duração dos despertares noturnos:				
	Latência do sono (Tempo necessário para adormecer):				
	Latência do sono após despertar noturno:				
			Sim	Não	
Você está satisfeito (a) com o seu sono? <i>Considerar resposta do paciente e/ou do cuidador/familiar</i>					
Relato de “soneca” (sesta) após o almoço ou durante o dia? Frequência: Duração:					
Apresenta sonolência excessiva, cochilos ou fadiga que interferem no desempenho das tarefas do dia?					
O parceiro, cuidador ou outros observadores relatam a presença de:	Comportamentos incomuns durante o sono (agitação psicomotora, agressividade, movimentação anormal, sonambulismo, etc)				
	Alterações respiratórias, como ronco excessivo ou pausa na respiração (apneias testemunhadas, asfixia, sensação de sufocação, “engasgo” noturno ou respiração ofegante), com duração ≥ 10 segundos.				
Relato de movimentação anormal das pernas ou outras partes do corpo para alívio de sensações desconfortáveis.					
Presença de sintomas matinais, como:	Boca seca (xerostomia)				
	Cefaléia				
Duração da sintomatologia superior a 3 meses					
Descrição detalhada do transtorno do sono-vigília:					

Quadro 12 :Principais transtornos do ciclo sono-vigília no idoso

	Envelhecimento	Ritmo Circadiano Avanço de Fase	Apnéia Obstrutiva do Sono	Transtorno Comportamental do Sono REM	Transtorno Comportamental do Sono Não-REM	Síndrome das Pernas Inquietas (SPI)/ Movimento Periódico dos Membros (MPM)	Insônia
Horários do sono noturno	Mais cedo	Muito cedo	-	-	-	-	Insônia inicial
	Mais cedo	Muito cedo	-	-	-	-	Insônia terminal
	Redução 6 a 7 horas	-	Redução	Redução	Redução	-	Redução
	Aumento	-	Aumento	Aumento	Aumento	-	Aumento
	Aumento 20 min	-	-	-	-	-	Aumento
Você está satisfeito (a) com o seu sono? (idoso ou sua família/cuidador)	Aumento 20 min	-	-	-	-	-	Aumento
	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Relato de "soneca" (sesta) após o almoço ou durante o dia?	Não	Não	Sim Epworth ≥ 10 pontos	Sim	Sim	Sim	Sim
Apresenta sonolência excessiva, cochilos ou fadiga durante o dia?	Não	Não	-	Sim	Sim	Não	Não
O parceiro, cuidador ou outros observadores relatam a presença de:	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
Relato de necessidade incontrolável de movimentar as pernas (ou outras partes do corpo) para alívio de sensações desconfortáveis e desagradáveis nas pernas (parestésias inespecíficas, como dor, prurido, formigamento, sensação de "arrepio", etc)	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não
Presença de sintomas matinais, como:	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Duração da sintomatologia superior a 3 meses	Boca seca (xerostomia)	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
	Cefaléia	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Descrição detalhada do transtorno do sono-vigília:	-	-	Obesidade, homens. Diferencial de Apnéia Central do Sono e Respiração Cheyne- Stokes	Alto risco de agressão física ao parceiro. Pesadelos com alto conteúdo emocional percebido pelo paciente. Verbalização agressiva. Pródromo das altas sinudeinopatias.	Sonambulismo, terror noturno e distúrbio alimentar. Alucinações hipnagógicas (despertar) e hipnagógicas (adormecer).	SPI : movimentação das pernas com repouso e no sono, que melhoram com a movimentação. MPM : movimentos dos membros, mmii ou cabeça somente no sono. Deficiência de ferro. Disfunção dopaminérgica.	Insatisfação com o sono

Saúde Bucal

Os profissionais da área de saúde devem estar preparados para a realização de uma boa avaliação da cavidade bucal, particularmente em idosos frágeis. O edentulismo está presente em mais da metade dos idosos, prejudicando a capacidade mastigatória. A qualidade do rebordo ósseo residual, entre outros fatores locais, muitas vezes dificulta a reabilitação protética desses indivíduos. Outro problema relacionado às próteses dentárias refere-se à sua condição de higiene. A qualidade de limpeza das próteses odontológicas dos idosos, por motivos diversos, geralmente é considerada ruim. A limpeza de dentaduras e próteses parciais removíveis deve ser considerada no momento da avaliação bucal. A colonização de próteses dentárias por patógenos da cavidade bucal está relacionada a lesões de mucosa, como a candidíase.

Na avaliação da cavidade bucal, deve-se estar atento para a presença de câncer de boca. O uso de próteses por muitos anos pode ocasionar desgastes nos dentes, fraturas e outros problemas relacionados ao uso constante. Esses problemas podem levar ao desenvolvimento de hiperplasias e leucoplasias, predispondo ao aparecimento de lesões malignas, particularmente quando associadas ao fumo. Em relação ao fluxo salivar, a avaliação de indivíduos idosos saudáveis mostra que o fluxo de saliva integral estimulada não diminui com a idade. A hipossalivação é a redução no fluxo salivar. A sensação de boca seca ou xerostomia refere-se a uma sensação subjetiva. Diversas drogas podem reduzir o fluxo salivar, como anticolinérgicas, antidepressivos e anti-hipertensivos, entre outras. A redução do fluxo salivar afeta funções bucais como mastigação, fonação e deglutição. Além disso, altera o equilíbrio do processo de des-mineralização e remineralização que ocorre entre a superfície dos dentes e o fluido da placa bacteriana, favorecendo o desenvolvimento da cárie dentária. A doença periodontal é um processo inflamatório provocado por bactérias que acometem os tecidos gengival e ósseo. Essa doença causa destruição dos tecidos de suporte dos dentes (gengiva e osso alveolar) em surtos aleatórios e em sítios específicos, podendo levar à mobilidade e à perda do elemento dental. A incapacidade cognitiva e a imobilidade limitam a higiene bucal, causando deterioração dos tecidos periodontais, devido ao acúmulo de placa. A recessão gengival é outra alteração facilmente encontrada nessa faixa etária (Moraes, 2016).

A avaliação da saúde bucal deve ser feita rotineiramente, podendo-se utilizar o seguinte instrumento de triagem apresentado no Quadro 13.

Quadro 13: Avaliação da Saúde Bucal

Mini-Avaliação da Saúde bucal		
Observar a presença de:	Sim	Não
Diminuição da quantidade de alimentos ou mudança no tipo de alimentação por causa dos dentes?		
Problemas de mastigação		
Sensibilidade exagerada a alimentos ou líquidos nos dentes ou gengivas?		
Edentulismo		
Prótese dentária		
Xerostomia		
Feridas ou lesões na mucosa oral ou língua		
Sangramento gengival		
Oroscopia:		
Data da última visita ao dentista:		

Sistemas fisiológicos propriamente ditos

A preservação dos sistemas e subsistemas funcionais depende da integridade dos sistemas fisiológicos clássicos, representados pelo sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, geniturinário, neurológico, locomotor, endócrino-metabólico, hematopoiético e tegumentar (pele e anexos) (Quadro 14). A revisão dos sistemas fisiológicos principais segue a mesma sistematização da avaliação clínica habitual, lembrando-se sempre dos sintomas mais frequentes nessa faixa etária e das alterações fisiológicas do envelhecimento. As queixas apresentadas pelo paciente são habitualmente subestimadas pelos familiares e pelo próprio idoso, retardando o diagnóstico. O hábito de atribuir-se toda sintomatologia aos problemas “da idade” são amplamente aceitos, inclusive pelos profissionais da área da saúde. Diferenciar as alterações fisiológicas do envelhecimento (senescência) das doenças, disfunções e incapacidades (senilidade) que podem se acumular com a passagem do tempo é tarefa difícil. A polipatologia é, muitas vezes, confundida com problemas psíquicos (“paciente poliqueixoso”), dificultando mais ainda o diagnóstico precoce dos problemas de saúde no idoso. Como regra geral, nenhuma sintomatologia causadora de incapacidades funcionais deve ser atribuída ao envelhecimento fisiológico per se. A expressão “da idade” não deve ser utilizada até que ampla avaliação diagnóstica exclua as doenças mais prevalentes nessa faixa etária. Com frequência, a queixa principal no momento da consulta não reflete, de forma clara e direta, a verdadeira origem do problema. Na verdade, o motivo da consulta corresponde, com mais frequência, ao sintoma mais familiar ou mais facilmente reconhecido, ao que requer mais cuidado ou ao problema que, na opinião do paciente ou do cuidador, permite legitimar o acesso ao sistema de saúde. Nem sempre as condições frequentemente associadas à velhice, como as quedas, incontinência urinária ou incapacidade cognitiva, constituem a queixa principal, apesar de estarem frequentemente presentes.

O raciocínio clínico tradicional de explicar todos os sinais e sintomas por uma única doença (unidade diagnóstica) não se aplica ao idoso. A presença de comorbidades ou polipatologia altera a apresentação das doenças, tornando-as atípicas, ou melhor, típicas do idoso. Na literatura médica, é comum falar-se em “apresentação atípica das doenças no idoso”. Na verdade, a apresentação é atípica somente quando o referencial é o jovem e típica quando se trata do paciente idoso. Comumente, a desordem em um órgão pode se manifestar por sintomas em outros, especialmente na presença de comorbidades, de tal forma que o órgão usualmente associado a determinado sintoma é menos provável de ser a fonte do problema principal. Por exemplo, confusão mental pode ser manifestação de infecção urinária e não necessariamente do comprometimento direto do sistema nervoso central (Moraes, 2016).

	Anamnese	Exame Físico	Exames Complementares
Pele/Anexos			
Sistema Cardiovascular			
Sistema Respiratório			
Sistema Digestivo			
Sistema Genitourinario			
Sistema Locomotor			
Sistema Neurológico			
Sistem Endócrino-Metabólico			
Sistema Hematopoiético			

Medicamentos

A instabilidade homeostática característica do idoso, particularmente, do idoso frágil, deve ser considerada na fase de decisão do uso do fármaco, escolha da dose e da velocidade de titulação da dose. A resposta do indivíduo aos medicamentos também varia ao longo do tempo e torna-se progressivamente mais imprevisível, em virtude da variabilidade fisiológica entre os idosos, aliada à maior prevalência de comorbidades e polifarmácia. Além disso, os idosos muito idosos e, particularmente, os idosos frágeis, portadores de comorbidades múltiplas, poli-incapacidades, polifarmácia, dependência funcional são raramente incluídos nos estudos que avaliam eficácia e segurança dos fármacos, o que torna o processo terapêutico no idoso desconhecido. A Prescrição Inapropriada (PI), consiste na utilização de medicamentos que apresentam uma relação risco-benefício desfavorável, particularmente quando existem outras intervenções terapêuticas, medicamentosas ou não, associadas a menor risco para o paciente. Inclui também o uso de medicamentos com posologia inadequada (dose, frequência ou duração superior à recomendada), interações perigosas (fármaco-fármaco ou fármaco-doença ou fármaco-alimento) e a subutilização de medicamentos claramente indicados em determinadas condições de saúde por razões obscuras, colocando em risco a saúde do paciente (Moraes, 2023).

A adequação de determinado medicamento pode ser prevista através do uso de indicadores de processo ou pelo uso de medidas de resultados. Os indicadores de processo são aquelas informações previamente estabelecidas por evidências científicas que mostram os riscos associados a determinados medicamentos, independentemente dos fatores relacionados ao paciente (Critérios Explícitos). Os indicadores de resultados ou de desfecho clínico consideram os fatores relacionados ao medicamento, mas também os fatores específicos da condição clínica do paciente (Critérios Implícitos). Na prática clínica, os critérios implícitos respondem pela maioria das prescrições inapropriadas e reações adversas a medicamentos em idosos. Todavia, são mais difíceis de serem obtidos, pois exigem o julgamento clínico, que só pode ser obtido através da Avaliação Geriátrica Ampla, capaz de definir as metas terapêuticas e prioridades específicas do paciente. O critério de Beers foi pioneiro e é aquele com maior número de revisões, com grande ampliação de sua abrangência e representatividade. Todavia, a validação do seu impacto não é expressiva e apresenta limitação de abranger apenas medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico dos EUA. Menos de 50% dos critérios disponíveis foram devidamente validados, limitando seu uso na prática clínica. O Sistema FORTA (Fit for The Aged) e o STOPP (Screening Tool of Older People's Prescriptions) / START (Screening Tool to Alert to Right Treatment) apresentam dados mais robustos na prevenção das RAM e avaliação do impacto nos desfechos mais importantes nos idosos. Todas as listas de critérios explícitos facilitam o reconhecimento da prescrição inapropriada, apesar da ênfase maior ser dada na lista negativa, ou seja, nos medicamentos que não devem ser utilizados em idosos ou em determinadas condições clínicas. Alguns critérios explícitos englobam também as listas positivas, ou seja, os medicamentos que devem ser utilizados pelos idosos portadores de algumas condições clínicas. Outro aspecto útil das listas é a sugestão de terapias alternativas ou ajustes nos medicamentos, de acordo com o paciente ou com a função renal ou expectativa de vida (Moraes, 2018).

Todo fármaco utilizado pelo idoso deve ter sua carga anticolinérgica, antidopaminérgica e sedativa avaliada rigorosamente, além do risco de hipotensão ortostática, quedas, hiponatremia e prolongamento do intervalo QTc (Quadro 15). Existem várias tabelas disponíveis na literatura para o prescritor consultar antes de utilizar determinado fármaco (Moraes, 2019).

Quadro 15: Avaliação dos Medicamentos em Uso[illegible]

História pessoal e hábitos de vida

A história pregressa deve incluir todas as informações referentes aos diag- nósticos prévios, internações, cirurgias e os procedimentos diagnósticos. Deve ser investigada a presença de tabagismo, etilismo, sexualidade, atividade física, direção veicular, imunização e uso de órteses ou próteses.

Fatores contextuais

Suporte familiar e social

A família tem a missão de educar, acolher, amparar e cuidar dos seus membros que encontram-se incapazes de fazê-lo de forma independente. A perda da independência e autonomia exige que a família assuma integralmente essa função desafiadora do cuidado integral, levando a um remodelamento, da dinâmica familiar. A rápida transição demográfica brasileira agrava mais ainda a situação, na medida em que famílias menores apresentam maiores limitações de prover os cuidados, dar apoio e suporte ao idoso frágil. Essa situação, também conhecida como insuficiência familiar, não pode ser confundida com negligência ou abandono, pois, muitas vezes, a família deseja cuidar do seu idoso dependente, mas não reúne as condições necessárias para fazê-lo. É relativamente recente e, portanto, incipiente, o estabelecimento de políticas públicas para pessoas idosas frágeis, dependentes e suas famílias. O Estado tem o dever de prover políticas públicas preventivas, evitando que a pobreza ronde o espaço das relações humanas, pois condições sociais de pobreza presentes no processo de desenvolvimento das famílias podem favorecer o rompimento dos vínculos familiares. Prover cuidado a idosos frágeis, a idosos dependentes, e oferecer suporte à família cuidadora, são grandes desafios colocados hoje para esses idosos, para suas famílias e para as políticas públicas. Gobbens (2010) destaca a importância dos outros determinantes da saúde, como sexo, raça/cor, escolaridade, estado civil, arranjos familiares, viuvez recente, idoso cuidador, participação e apoio social, acesso a serviços e situação laboral. Portanto, percebe-se claramente a importância da avaliação do suporte familiar e social na AGA.

A avaliação do suporte familiar e social deve incluir as seguintes questões (Quadro 16 e 17)

Quadro 16: Suporte Familiar

Avaliação do Suporte Familiar		Sim	Não
Moradia	O sr(a) mora sozinho?		
	O sr(a) reside com familiares ou amigos?		
	O sr(a) reside em ILPI?		
Cônjuge ou Companheiro	O sr(a) tem cônjuge ou companheiro?		
	O sr(a) ficou viúva(o) no último ano?		
Apoio nas atividades de vida diária	O sr(a) tem familiares/cuidadores ou amigos com disponibilidade para atendê-lo plenamente na realização das tarefas do cotidiano, em caso de necessidade?		
Interação familiar e comunitária	O sr(a) recebe ou faz visitas a familiares, amigos ou vizinhos com regularidade?		
	O sr (a) sente falta de maior convívio com familiares ou amigos?		
Sobrecarga familiar	O sr(a) é responsável pelo cuidado de pessoas dependentes no seu domicílio?		
	O sr(a) reside com pessoas que possam causar desorganização no convívio familiar?		

Quadro 17: Suporte social

Avaliação do Suporte Social		Sim	Não
Renda	O sr(a) tem acesso à renda própria, do tipo benefício previdenciário?		
	O sr(a) tem acesso à renda própria, do tipo benefício assistencial (LOAS/BPC)?		
	O sr(a) tem acesso à renda de terceiros, em caso de necessidade?		
Escolaridade	O sr(a) é capaz de ler e escrever?		
Condições da Moradia	O sr(a) tem moradia própria?		
	A sua moradia está em boas condições de organização, segurança e higiene?		
Participação Social	O sr(a) participa de eventos ou atividades extradomiciliares ou comunitária ou rede social, como trabalho, família, igreja, grupo de convivência, lazer, etc?		

Foram desenvolvidos vários instrumentos com o objetivo de reconhecer a fragilidade sociofamiliar, dentre os quais podemos citar:

- **Tilburg Frailty Indicator (TFI):** é um instrumento utilizado na Holanda, que inclui os componentes físicos, psicológicos e sócio-demográficos (idade, sexo, etnia, estado civil, escolaridade e renda) da fragilidade (Gobbens, 2010). O TFI é constituído por duas partes, A e B. A parte A é voltada para os determinantes da fragilidade, como idade, sexo, estado civil, etnia, escolaridade, renda, estilo de vida, presença de comorbidades e de eventos de vida (perda de entes queridos, doença grave, etc) e satisfação com moradia. A parte B refere-se à identificação da fragilidade propriamente dita e é constituída por 15 questões objetivas, autorreferidas, distribuídas em três domínios: físico, psicológico e social. Este instrumento foi adaptado para a população brasileira por Santiago e cols, em 2012, que demonstrou alta equivalência semântica, elevado percentual de entendimento e boa aceitação dos itens do instrumento por parte dos idosos brasileiros. O domínio social inclui três perguntas:

- Você mora sozinho?
- Você sente falta de ter pessoas ao seu lado?
- Você tem apoio suficiente de outras pessoas?

- **Groningen Frailty Indicator:** é um instrumento de triagem rápida com caráter multidimensional e que pode ser aplicado em clínicas geriátricas, instituições de longa permanência, unidades de urgência, centros cirúrgicos, etc (Steverink, 2001). A dimensão psicossocial utiliza as seguintes perguntas (J Health Biol Sci, 2019;7:242-247):
 - O(a) Sr(a) costuma sentir um vazio em torno de sua vida?
 - O(a) Sr(a) costuma sentir falta de pessoa ao seu redor?
 - O(a) Sr(a) costuma se sentir abandonado(a)?
 - O(a) Sr(a), ultimamente, tem se sentido triste ou deprimido(a)?
 - O(a) Sr(a), ultimamente, tem se sentido nervoso(a) ou ansioso(a)?
- **APGAR da Família:** é um instrumento que avalia a satisfação do indivíduo com os membros da família em relação a cinco dimensões da dinâmica familiar: adaptação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e capacidade resolutive (Duarte YAO, Domingues MAR, 2020). O instrumento foi validado no Brasil e utiliza cinco perguntas, cujas respostas variam de sempre (2 pontos), algumas vezes (1 ponto) e nunca (0). O escore varia de 0 a 10 pontos com a seguinte interpretação: 0 a 4 pontos (elevada disfunção familiar); 5 a 6 pontos (moderada disfunção familiar) e 7 a 10 pontos (boa funcionalidade familiar). As perguntas são:
 - Estou satisfeito (a) pois posso recorrer à minha família em busca de ajuda quando alguma coisa está me incomodando ou preocupando.
 - Estou satisfeito (a) com a maneira pela qual minha família e eu conversamos e compartilhamos os problemas.
 - Estou satisfeito (a) com a maneira como minha família aceita e apoia meus desejos de iniciar ou buscar novas atividades e procurar novos caminhos ou direções.
 - Estou satisfeito (a) com a maneira pela qual minha família demonstra afeição e reage às minhas emoções, tais como raiva, mágoa ou amor.
 - Estou satisfeito (a) com a maneira pela qual minha família e eu compartilhamos o tempo juntos.
- **Makizako Social Frailty Index:** o questionário é composto por cinco perguntas sobre o contexto social e familiar do paciente (Makizalko, 2015). O escore é baseado no número de respostas negativas: não frágil (0), pré-frágil (1 ponto) e frágil (≥ 2 pontos). O instrumento não foi validado no Brasil.

Quadro 18: Questionário de Makizako

Makizako Social Frailty Index	Índice de Fragilidade Social de Makizako
Living alone (yes)	Morar sozinho (sim)
Going out less frequently compared with last year (yes)	Sair com menos frequência em comparação com o ano passado (sim)
Feeling helpful to friends or family (no)	Sentir-se útil para amigos ou familiares (não)
Visiting friends sometimes (no)	Visitar amigos às vezes (não)
Talking with someone everyday (no)	Conversar com alguém todos os dias (não)

- **Social Frailty Screening Index:** é composto por quatro perguntas sobre o contexto social e familiar do paciente (Makizalko, 2015), que inclui uma pergunta sobre a condição econômica. O escore é baseado no número de respostas negativas: robusto (0), pré-frágil (1 ponto) e frágil (≥ 2 pontos). O instrumento não foi validado no Brasil (Quadro 19).

Quadro 19: Índice de Triagem de Fragilidade Social

Social Frailty Screening Index	Índice de Triagem de Fragilidade Social
1. Are you satisfied with your economic condition? The answer choices included (a) very satisfied, (b) satisfied, (c) unsatisfied, and (d) very unsatisfied. “Poor general resources (1 point)” was operationally defined as an answer of (d).	1. Você está satisfeito com sua condição econômica? As opções de resposta incluem (a) muito satisfeito, (b) satisfeito, (c) insatisfeito e (d) muito insatisfeito. “Poucos recursos gerais (1 ponto)” foi definido operacionalmente como uma resposta de (d).
2. Do you live alone? Poor social resources (1 point)” was defined as living alone.	2. Você mora sozinho? Pobres recursos sociais (1 ponto)” foi definido como viver sozinho.
3. Which social activities do you participate in (multiple answers allowed)? The answer choices included (a) local festivals or events, (b) community activities in the neighborhood, (c) self- management groups, and (d) volunteer activities. “Poor social behavior (1 point)” was operationally defined as participating in none of these activities.	3. Você participa de quais atividades sociais (múltiplas respostas são permitidas)? As opções de resposta incluíam (a) festivais ou eventos locais, (b) atividades comunitárias na vizinhança, (c) grupos de autogestão e (d) atividades voluntárias. “Comportamento social ruim (1 ponto)” foi operacionalmente definido como não participar de nenhuma dessas atividades.

4. How do you get along with your neighbors?

The answer choices included (a) I have a neighbor who comes and goes to each house, (b) I have a neighbor to chat with on the street, (c) I have a neighbor to say hello to, and (d) I do not communicate with neighbors.

"Poor fulfillment of basic social needs (1 point)" was defined as an answer of (c) or (d).

4. Como você se dá com seus vizinhos?

As opções de resposta incluíam (a) tenho um vizinho que vem e vai em cada casa, (b) tenho um vizinho para conversar na rua, (c) tenho um vizinho para cumprimentar e (d) não se comunica com os vizinhos.

"Satisfação insuficiente das necessidades sociais básicas (1 ponto)" foi definida como uma resposta de (c) ou (d).

Segurança ambiental

A avaliação ambiental também é considerada essencial. As áreas de locomoção, iluminação, quarto de dormir, banheiro, cozinha e escada devem ser priorizadas. Cerca de 25% dos idosos caem dentro de suas próprias casas pelo menos uma vez por ano. A interação de fatores intrínsecos e extrínsecos ou ambientais está presente na maioria das quedas. Entre os diversos fatores causadores de quedas em idosos, destacamos a especificação inadequada de materiais de acabamento do piso, que por muitas vezes é feita sem considerar a necessidade específica de quem vai utilizar esse espaço. Partindo desse fato, as pessoas idosas devem se beneficiar de intervenções no planejamento de ambientes que compensem as suas perdas funcionais. Assim, considera-se de fundamental importância que os espaços físicos sejam aprimorados, aumentando suas qualidades funcionais, em conformidade com as necessidades dos usuários que viverão ali. Dessa forma acredita-se que a ideia do espaço para todos, possa ser uma ferramenta a ser incorporada ao processo de criação, onde a segurança e a acessibilidade passam a ser fatores relevantes (VIDIGAL; CASSIANO., 2009).

Saúde do Cuidador

A avaliação da saúde física e mental do cuidador é considerada fundamental na avaliação multidimensional da pessoa idosa. O cuidador de idosos usualmente é um familiar, do sexo feminino e, muitas vezes, é também idoso. Na sua maioria são pessoas não qualificadas, que assumiram o papel de cuidador pela disponibilidade, instinto ou vontade. É frequente encontrarmos cuidadores idosos, por vezes, tão ou mais frágeis que os idosos que estão sendo cuidados. Apresentam fragilidades orgânicas e emocionais, vivenciando um alto nível de estresse e demandando mais atenção que o próprio paciente. Nos EUA estudos mostram que aproximadamente 35% dos cuidadores tinham 65 anos ou mais e quase 10% deles tinham mais de 75 anos. No Brasil, a realidade não se faz muito diferente, com o agravante dos altos índices de analfabetismo. Além disso, muitos idosos vivem em condições precárias, tendo a aposentadoria como única fonte de renda para todo o grupo familiar (Duarte et al., 2009). O Inventário de Sobrecarga de Zarit consiste em 22 questões (Quadro 20), que avaliar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidador e inclui informações sobre saúde, vida social, vida pessoal, situação financeira, situação emocional e tipo de relacionamento. Cada item foi pontuado como: nunca (0), quase nunca (1), às vezes (2), muitas vezes (3) e quase sempre (4) (Sczufca, 2002). Pode-se utilizar a versão reduzida, com sete perguntas (Brasil, 2013) (Quadro 21).

Quadro 20: Inventário de Sobrecarga de Zarit

Table 1 – Burden Interview (Zarit & Zarit, 1987; tradução para o português: Marcia Sczufca)

INSTRUÇÕES: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas algumas vezes sentem-se quando cuidam de outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que frequência o Sr/Sra se sente daquela maneira(nunca=0, raramente=1, algumas vezes=2, frequentemente=3, ou sempre=4). Não existem respostas certas ou erradas.

1. O Sr/Sra sente que S* pede mais ajuda do que ele (ela) necessita?
2. O Sr/Sra sente que por causa do tempo que o Sr/Sra gasta com S, o Sr/Sra não tem tempo suficiente para si mesmo (a)?
3. O Sr/Sra se sente estressado (a) entre cuidar de S e suas outras responsabilidades com a família e o trabalho?
4. O Sr/Sra se sente envergonhado (a) com o comportamento de S?
5. O Sr/Sra se sente irritado (a) quando S está por perto?
6. O Sr/Sra sente que S afeta negativamente seus relacionamentos com outros membros da família ou amigos?
7. O Sr/Sra sente receio pelo futuro de S?
8. O Sr/Sra sente que S depende do Sr/Sra?
9. O Sr/Sra se sente tenso (a) quando S esta por perto?
10. O Sr/Sra sente que a sua saúde foi afetada por causa do seu envolvimento com S?
11. O Sr/Sra sente que o Sr/Sra não tem tanta privacidade como gostaria, por causa de S?
12. O Sr/Sra sente que a sua vida social tem sido prejudicada porque o Sr/Sra está cuidando de S?
13. O Sr/Sra não se sente à vontade de ter visitas em casa, por causa de S?
14. O Sr/Sra sente que S espera que o Sr/Sra cuide dele/dela, como se o Sr/Sra fosse a única pessoa de quem ele/ela pode depender?
15. O Sr/Sra sente que não tem dinheiro suficiente para cuidar de S, somando-se as suas outras despesas?
16. O Sr/Sra sente que será incapaz de cuidar de S por muito mais tempo?
17. O Sr/Sra sente que perdeu o controle da sua vida desde a doença de S?
18. O Sr/Sra gostaria de simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de S?
19. O Sr/Sra se sente em dúvida sobre o que fazer por S?
20. O Sr/Sra sente que deveria estar fazendo mais por S?
21. O Sr/Sra sente que poderia cuidar melhor de S?
22. De uma maneira geral, quanto o Sr/Sra se sente sobrecarregado (a) por cuidar de S**?

*No texto S refere-se a quem é cuidado pelo entrevistado. Durante a entrevista, o entrevistador usa o nome desta pessoa. **Neste item as respostas são: nem um pouco=0, um pouco=1, moderadamente=2, muito=3, extremamente=4.

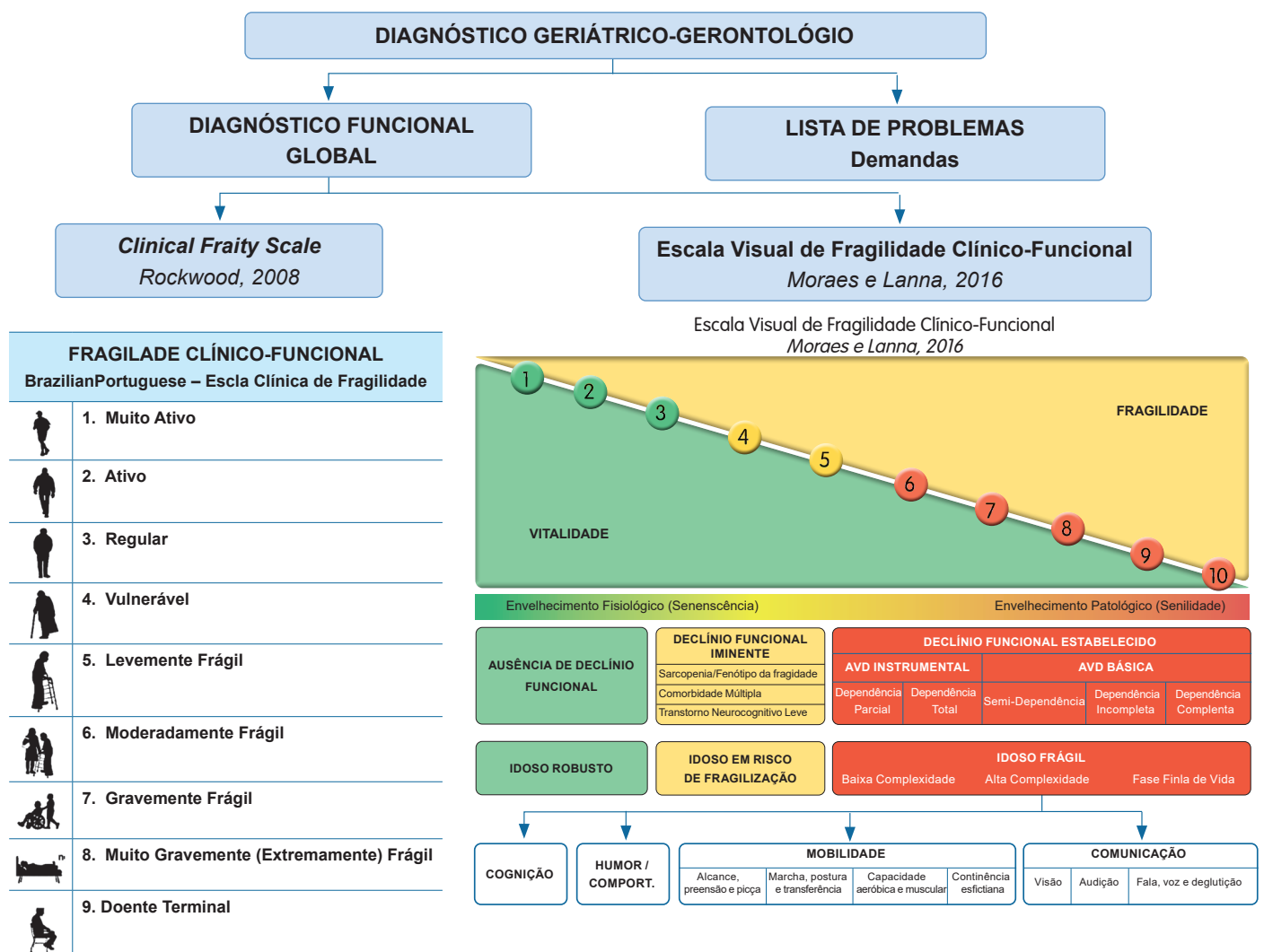
Quadro 21: Inventário de Sobrecarga de Zarit Reduzido

	Nunca 1	Quase Nunca 2	Às vezes 3	Frequentemente 4	Quase Sempre 5
1. Sente que, por causa do tempo que utiliza com o seu familiar/doente já não tem tempo suficiente para você mesmo?					
2. Sente-se estressado/angustiado por ter que cuidar do seu familiar/doente e ao mesmo tempo ser responsável por outras tarefas? (ex.: cuidar de outros familiares, ter que trabalhar).					
3. Acha que a situação atual afeta a sua relação com amigos ou outros elementos da família de uma forma negativa?					
4. Sente-se exausto quando tem de estar junto do seu familiar/doente?					
5. Sente que sua saúde tem sido afetada por ter que cuidar do seu familiar/doente?					
6. Sente que tem perdido o controle da sua vida desde que a doença o seu familiar/ doente se manifestou?					
7. No geral, sente-se muito sobrecarregado por ter que cuidar do seu familiar/ doente?					
Pontuação Final					
Interpretação - Sobrecarga leve: até 14 pontos - Sobrecarga moderada: 15 a 21 pontos - Sobrecarga grave: acima de 22 pontos					

Diagnóstico Geriátrico-Gerontológico

O diagnóstico geriátrico-gerontológico deve incluir o diagnóstico funcional global e a lista de problemas ou demandas do paciente e de sua família (Figura 10).

Figura 10: Diagnóstico Geriátrico-Gerontológico



Diagnóstico Funcional Global:

É fundamental para mostrar a heterogeneidade entre os idosos, de acordo com a sua capacidade funcional e, a partir daí, traçarmos as estratégias de intervenções a serem indicadas no plano de cuidados personalizado. Existem diversas classificações disponíveis e não há consenso da superioridade entre elas. Apresentamos a Clinical Frailty Scale (CFS), proposta por Rockwood (2005) e Escala Visual de Fragilidade, proposta por Moraes e Lanna (2016).

Clinical Frailty Scale (CFS), proposta por Rockwood (2005)

Foi desenvolvida por Rockwood et al e validada no Brasil por Rodrigues et al em 2021. É uma escala ordinal, baseada em uma visão holística do paciente, com foco em sua saúde geral e na capacidade de realizar as atividades de vida diária (AVD). Cada incremento de pontuação aumenta significativamente os riscos de mortalidade e institucionalização em médio prazo. Dada a facilidade de administrar o CFS, isso pode facilitar a incorporação da fragilidade na triagem de rotina e nos algoritmos de tomada de decisão clínica. Além disso, a CFS tem se mostrado mais fácil de aplicar e oferece maior confiabilidade em comparação com outras escalas (Quadro 22).

Quadro 22: CFS

Escala Clínica de Fragilidade*



1. Muito Ativo - Pessoas que estão robustas, ativas, com energia e motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente. Elas estão entre as mais ativas para a sua idade.



2. Ativo - Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas que as da categoria 1. Frequentemente se exercitam ou são muito ativas ocasionalmente. exemplo: em determinada época do ano.



3. Regular - Pessoas com problemas de saúde bem controlados, mas não se exercitam regularmente além da caminhada de rotina.



4. Vulnerável - Apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as atividades. Uma queixa comum é sentir-se mais lento e/ou mais cansado ao longo do dia.



5. Levemente Frágil - Estas pessoas frequentemente apresentam lentidão evidente e precisam de ajuda para atividades instrumentais de vida diária (AIVD) mais complexas (finanças, transporte, trabalho doméstico pesado, medicações). Tipicamente, a fragilidade leve progressivamente prejudica as compras e passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas.



6. Moderadamente Frágil - Pessoas que precisam de ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa, frequentemente têm dificuldades com escadas e necessitam de ajuda no banho e podem necessitar de ajuda mínima (apoio próximo) para se vestirem.



7. Muito Frágil - Completamente dependentes para cuidados pessoais, por qualquer causa (física ou cognitiva). No entanto, são aparentemente estáveis e sem alto risco de morte (dentro de 6 meses).



8. Severamente Frágil - Completamente dependentes, aproximando-se do fim da vida. Tipicamente incapazes de se recuperarem de uma doença leve.



9. Doente Terminal - Aproximando-se do fim da vida. Esta categoria se aplica a pessoas com expectativa de vida < 6 meses, sem outra evidência de fragilidade.

Pontuando fragilidade em pessoas com demência

O grau de fragilidade corresponde ao grau de demência. Sintomas comuns na demência leve incluem esquecimento dos detalhes de um evento recente, apesar da recordação do evento em si, repetindo a mesma pergunta/história e afastamento de eventos sociais.

Na demência moderada, a memória recente está muito comprometida apesar de aparentemente lembrar bem de fatos do passado. Quando solicitadas, elas são capazes de fazer o cuidado pessoal.

Na demência severa, elas não conseguem realizar cuidados pessoais sem ajuda.

1. Canadian Study on Health & Aging, Revised 2008.
2. K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 113:489-495.

©2009. Version 1.2_EN; ©2018. Version 1.0_Port AU rights reserved. Geriatric Medicine Research. Dalhousie University, Halifax, Canada. Permission granted

Escala Visual de Fragilidade Clínico Funcional, proposta por Moraes e Lanna (2016)

A Escala Visual de Fragilidade Clínico Funcional, proposta por Moraes e Lanna (2016) é expressão visual da Classificação Clínico Funcional do Idoso, proposta por Moraes e Lanna, em 2016 (Quadro 23). Apresenta de forma mais clara os vários subtipos de idosos, exibindo extremos opostos de capacidade funcional, que representam o grau máximo e mínimo de vitalidade e fragilidade. Esses extremos estão ligados por uma linha reta, contínua, mas declinante, onde pode ser marcado o ponto em que o idoso se encontra. Foram predefinidos 10 estratos ou categorias clínico-funcionais, que são agrupados em três grandes grupos de idosos: idoso robusto (estratos 1 a 3), em risco de fragilização (estratos 4 e 5) e frágil (estratos 6 a 10) (Figura 10). Os idosos frágeis, por sua vez, podem ser classificados, conforme a necessidade de acompanhamento geriátrico-gerontológico especializado, em idosos de alta complexidade, baixa complexidade e em fase final de vida, como pode ser observado no quadro 23.

Quadro 23: Classificação Clínico-Funcional do Idoso

ESCALA VISUAL DE FRAGILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL (Moraes e Lanna, 2016)				
Classificação Clínico-Funcional, segundo Moraes e Lanna, 2016				
IDOSOS ROBUSTOS				
Estrato 1	São idosos que se encontram no grau máximo de vitalidade. Apresentam independência para todas as AVD avançadas, instrumentais e básicas e ausência de doenças ou fatores de risco, exceto a própria idade. São indivíduos que envelheceram livres de doenças e não apresentam nenhuma outra condição de saúde preditora de desfechos adversos.			
Estrato 2	São idosos independentes para todas as AVD, mas que apresentam condições de saúde de baixa complexidade clínica, como a hipertensão arterial controlada e sem lesão de órgão alvo, diabetes mellitus controlado em sem lesão de órgão alvo, e fatores de risco, como tabagismo, dislipidemia, osteopenia, depressão leve, dentre outros.			
Estrato 3	São idosos independentes para todas as AVD, mas que apresentam doenças crônico-degenerativas com base em critérios diagnósticos bem estabelecidas e de maior complexidade clínica, como hipertensão arterial descontrolada ou com lesão de órgão alvo, diabetes mellitus descontrolado ou com lesão de órgão-alvo, depressão, ataque isquêmico transitório, acidente vascular cerebral, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica/asma, osteoartrite, doença arterial coronariana, história de IAM, doença arterial periférica, câncer não cutâneo, osteoporose densitométrica, dor crônica, fibrilação atrial, doença de Parkinson ou anemia. Neste grupo, não são incluídos fatores de risco.			
IDOSOS EM RISCO DE FRAGILIZAÇÃO				
Estrato 4	São idosos independentes para todas as AAVD, AIVD e ABVD, mas que apresentam uma das três condições abaixo: 1. Presença de qualquer evidência de redução da capacidade aeróbia/muscular, como redução da força e/ou massa muscular: perda de peso significativa, fadigabilidade, baixo nível de atividade física associada à redução objetiva da força muscular ou CP 31cm (idoso pré-frágil, segundo Fried 2001); 2. Presença de Comprometimento Cognitivo Leve ou Transtorno Neurocognitivo Leve; 3. Presença de comorbidade múltipla, definida como: • Presença de duas ou mais doenças crônico-degenerativas bem estabelecidas e de maior complexidade clínica (ver estrato 3). • Presença de 5 ou mais condições crônicas de saúde, incluindo as doenças crônico-degenerativas clássicas, enfermidades ("illness"), fatores de risco ou sintomas que necessitam de intervenção médica. • Polifarmácia: uso diário de 5 ou medicamentos de classes diferentes. • Internação recente, nos últimos 6 meses.			
Estrato 5	São idosos independentes para AIVD e ABVD, mas que apresentam uma das três condições abaixo: • Limitações nas AAVD (Atividades Avançadas de Vida Diária), definida como aquelas atividades relacionadas à integração social, atividades produtivas, recreativas e/ou sociais; • Evidências clínicas de redução significativa no desempenho muscular: VM ≤ 0,8 m/s ou TUG ≥ 20s, ou seja, presença de sarcopenia grave; • Presença do fenótipo de fragilidade de Fried 2001 (≥ 3 critérios).			
IDOSOS FRÁGEIS				
Estrato 6	São os idosos que apresentam declínio funcional parcial nas atividades instrumentais de vida diária e são independentes para as AVD básicas.	Baixa Complexidade	Alta Complexidade	Fase Final de Vida
Estrato 7	São os idosos que apresentam declínio funcional em todas as atividades instrumentais de vida diária, mas ainda são independentes para todas as atividades básicas de vida diária.	São idosos que apresentam declínio funcional estabelecido e baixo potencial de reversibilidade clínico-funcional. Nestes idosos, a gestão do caso pode ser realizada por equipes de saúde não especializadas, após realização da AGA, com elaboração do Plano de Cuidados Personalizado feito por equipe geriátrico-gerontológica especializada.	São idosos que apresentam dependência funcional nas atividades de vida diária associada a condições de saúde de difícil manejo, devido à dúvida diagnóstica ou terapêutica. O termo alta complexidade sugere elevado potencial de ganho funcional e/ou de qualidade de vida. Esses idosos são aqueles que mais se beneficiam do acompanhamento geriátrico-gerontológico especializado.	São idosos que apresentam dependência funcional estabelecida e sobrevida estimada menor que seis meses. O foco das intervenções é o cuidado paliativo, baseado no conforto do paciente e seus familiares.
Estrato 8	São os idosos que apresentam dependência completa nas AVD instrumentais associada à semi-dependência nas AVD básicas: comprometimento de uma das funções influenciadas pela cultura e aprendizado (banhar-se e/ou vestir-se e/ou uso do banheiro).			
Estrato 9	São os idosos que apresentam dependência completa nas AVD instrumentais associada à dependência incompleta nas AVD básicas: comprometimento de uma das funções vegetativas simples (transferência e/ou continência), além de, obviamente, ser dependente para banhar-se, vestir-se e usar o banheiro. A presença isolada de incontinência urinária não deve ser considerada, pois é uma função fisiológica e não uma atividade.			
Estrato 10	São os idosos que se encontram no grau máximo de fragilidade e, consequentemente, apresentam o máximo de dependência funcional, necessitando de ajuda, inclusive, para alimentar-se sozinho.			
A definição do estrato clínico-funcional deve considerar o melhor desempenho atual nas atividades de vida diária.				

AAVD: atividades avançadas de vida diária; AIVD: atividades instrumentais de vida diária; ABVD: atividades básicas de vida diária; CP: circunferência da panturrilha; CCL: comprometimento cognitivo leve; VM-4m: velocidade de marcha em 4 metros; TUG: Timed Up and GoTest

Lista de Problemas:

além do diagnóstico funcional global, o diagnóstico geriátrico-gerontológico deve incluir a lista de problemas, que contém todas as demandas biopsico-sociais ou condições de saúde identificadas na avaliação multidimensional. Esse conceito de condição de saúde é mais amplo e não se restringe à definição de doenças, mas sim, às circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas reativas ou proativas, eventuais ou contínuas, fragmentadas ou integradas dos sistemas de atenção à saúde (Mendes, 2011; OMS, 2003). Deve incluir as incapacidades funcionais ou “Grandes Síndromes Geriátricas”, as alterações nos sistemas fisiológicos (doenças clássicas, alterações do sono, distúrbios nutricionais, afecções na saúde bucal, etc), fatores de risco (dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, etc), estimativas de risco (categoria de risco cardiovascular, FRAX, etc), sintomas inespecíficos, uso de medicamentos potencialmente inapropriados ou de alto risco, enfim, todas as alterações percebidas nas dimensões da saúde avaliadas. Problemas identificados no suporte familiar, suporte social, segurança ambiental, lazer e saúde do cuidador também devem ser incluídos na lista de problemas.

Plano de Cuidados Personalizado

O Plano de Cuidados Personalizado (PCP) é a estratégia utilizada para a organização do cuidado, no qual se definem claramente quais são os problemas de saúde do paciente (o quê?), as intervenções mais apropriadas para melhoria da sua saúde (como?), as justificativas para as mudanças (por quê?), quais profissionais (quem?) e equipamentos de saúde (onde?) necessários para a implementação das intervenções capazes de “melhorar a vida da pessoa idosa, atual e futura”. Essas perguntas são complexas e devem ser respondidas por uma equipe interdisciplinar, respeitando-se as preferências, necessidades, desejos e valores da pessoa idosa e de sua família. Deve, portanto, conter todas as informações para o planejamento e implementação das ações necessárias para a manutenção ou recuperação da saúde do paciente. Pode ser considerado como uma estratégia norteadora da equipe de saúde para atendimento as necessidades específicas de saúde identificadas na AGA, no curto, médio e longo prazo, direcionando a equipe na busca dos recursos adequados e tratamentos requeridos, servindo como eixo condutor de todo processo assistencial. Assim, a sua elaboração deve ser cuidadosa, valorizando a efetividade e segurança das medidas curativas, paliativas, reabilitadoras e preventivas propostas para o paciente e sua família.

O PCP deve conter as decisões compartilhadas com a pessoa idosa e família e as intervenções preventivas/promocionais, curativas, paliativas e reabilitadoras sugeridas para todas as demandas de saúde identificadas na avaliação multidimensional. As decisões compartilhadas incluem as prioridades do cuidado, a definição da proporcionalidade terapêutica e as metas terapêuticas específicas. Os idosos frágeis apresentam múltiplas condições de saúde simultâneas e de complexidade clínica e repercussão clínica e funcional variáveis. Deve-se privilegiar as intervenções capazes de confortar o paciente, melhorar a autonomia e independência e aquelas associadas à mudança na história natural das doenças, com redução mais rápida da morbimortalidade. Intervenções que necessitam de longo prazo para obtenção de resultados devem ser compartilhadas com o paciente e família, particularmente nos idosos mais frágeis ou em fase final de vida. Assim, a definição da proporcionalidade terapêutica deve fazer parte do PCP, sempre que for possível. As ações que devem ser realizadas pelo cuidado profissional (equipe interdisciplinar) devem estar claras, assim como as mudanças comportamentais ou de estilo de vida do paciente e de sua família (autocuidado apoiado/cuidado familiar) (Figura 11).

Figura 11: Plano de Cuidados Personalizado



O PCP é essencial para apoiar os idosos frágeis e seus cuidadores, ajudando-os a desenvolver conhecimentos, habilidades e confiança para gerenciar sua própria saúde, cuidados e bem-estar. A pessoa idosa e sua família necessitam mais do que medicamentos ou tratamentos clínicos. As necessidades sociais, psicológicas e apoio, para realizarem as tarefas do cotidiano da forma mais independente possível, são igualmente importantes, juntamente com as oportunidades de inclusão e apoio comunitário (British Geriatrics Society, 2019).

As intervenções propostas podem ser preventivas ou promocionais, curativas, reabilitadoras ou paliativas:

- **Intervenções preventivas ou promocionais:** é o conjunto de medidas destinadas a desenvolver uma “saúde ótima”, promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Podem ser categorizadas em quatro tipos de abordagem: **aconselhamento** (mudanças de hábitos ou no estilo de vida), **rastreamento** (neoplasias, doença cardiovascular e osteoporose), **quimioprevenção** (uso de estatinas, AAS, vitaminas, hormônios etc.) e **imunização** (vacina anti-influenza, anti-covid19, herpes zoster, antipneumocócica etc.). A equipe interdisciplinar deve ter em mente que algumas intervenções preventivas ou promocionais, classicamente indicadas para o adulto, podem ter pouco ou

nenhum benefício no idoso frágil. Medidas que exigem mudanças comportamentais e de hábitos de vida, juntamente com a utilização de intervenções diagnósticas ("sobrediagnóstico") e terapêuticas ("sobretreatamento"), que demandam tempo demasiadamente longo para obtenção de resultados positivos, podem não ser custo-eficazes e, até mesmo, piorar mais ainda a condição de vida do paciente e de sua família.

- **Intervenções curativas e paliativas:** consistem nas ações direcionadas a problemas específicos. A ênfase é no diagnóstico correto das condições crônicas de saúde e na prescrição correta das intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Deve-se estar atento ao risco de iatrogenia medicamentosa, principalmente nos idosos frágeis. Por sua vez, as ações paliativas reservam-se àquelas situações em que não há possibilidade de cura ou modificação da história natural da doença. Nesses casos, o cuidado paliativo tem como objetivo o conforto e a melhora da qualidade de vida dos pacientes e familiares, diante de doenças que ameaçam continuamente a vida. O foco da intervenção não é somente o alívio impecável da dor, mas do conjunto de todos os sintomas de natureza física, emocional, espiritual e social.
- **Intervenções reabilitadoras:** é o conjunto de procedimentos aplicados aos indivíduos com incapacidades (deficiências, limitação de atividades ou restrição da participação), com o objetivo de manter ou restaurar a funcionalidade (funções do corpo, atividades e participação), maximizando sua independência e autonomia. As ações reabilitadoras são direcionadas ao indivíduo e aos fatores contextuais envolvidos no comprometimento funcional, representados pelos fatores ambientais (ambiente físico, social e de atitudes nas quais o indivíduo vive e conduz a sua vida) e pelos fatores pessoais (estilo de vida de um indivíduo). Dessa forma, a reabilitação abrangente atua nas seguintes dimensões da funcionalidade: mobilidade, comunicação, nutrição e saúde bucal (reabilitação física); cognição, humor, estado mental, sono e lazer (reabilitação cognitivo-comportamental); suporte social e familiar (reabilitação sociofamiliar) e no ambiente físico onde o indivíduo está inserido (reabilitação ambiental). A reabilitação do cuidado consiste nas orientações aos familiares e cuidadores quanto às melhores tecnologias do cuidado associadas a maior conforto ao paciente e menor sobrecarga ao cuidador. Essa multiplicidade de ações exige a participação integrada da medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, educação física, serviço social, nutrição, farmácia, musicoterapia e odontologia, dentre outras, dependendo de cada caso. Pressupõe a identificação de objetivos e a organização de ações praticadas dentro de um cronograma viável para as necessidades do paciente e a realidade do serviço. A qualidade do trabalho, a obtenção de resultados e o tempo dispendido para sua efetivação são reflexo do nível de comunicação entre seus membros. Essa comunicação diz respeito não só aos aspectos ligados ao paciente e sua evolução, mas, também, aos avanços tecnológicos de cada área, novas técnicas e estratégias de abordagem e tratamento.

A efetividade e segurança das intervenções propostas devem ser avaliadas cuidadosamente, pois o risco de iatrogenia é elevado no idoso frágil. Definimos iatrogenia como todo malefício ou agravo à saúde causado pelo cuidado profissional. A prevenção da iatrogenia ou prevenção quaternária deve ser sempre considerada no PCP, que pode ocorrer como consequência do excesso de rastreamento de doenças, medicalização excessiva e inapropriada, solicitação de exames em demasia e sem objetivo terapêutico definido, excesso de diagnósticos, uso de medicamentos fúteis ou potencialmente inapropriados e à medicina defensiva. O principal objetivo é não prejudicar o paciente ("*primum non nocere*"). Estes conceitos são fundamentais para a manutenção e/ou recuperação da independência e autonomia da pessoa idosa e, também, para a sustentabilidade dos sistemas de atenção à saúde, públicos ou privados.

O autocuidado apoiado / cuidado familiar consiste na sistematização de intervenções educacionais e de apoio realizadas pela equipe de saúde, com o intuito de ampliar a habilidade e a confiança da pessoa para gerenciar suas condições de saúde, apoiada por sua equipe de referência. Faz parte do processo de preparar as pessoas para que gerenciem sua saúde: ajudar a definir os problemas, estabelecer as prioridades, propor metas, elaborar os planos de cuidado e monitorar os resultados. Logo, o efetivo autocuidado vai além de uma simples consulta ou dizer às pessoas o que devem fazer (qual exame, qual medicamento e como usar), uma vez que deve enfatizar o papel central do usuário no gerenciamento de sua própria saúde (Mendes, 2019). Por outro lado, no idoso frágil, dependente para as atividades de vida diária, é necessário o envolvimento ativo da família, na figura do cuidador, responsável pelo cuidado direto com o idoso. Nestes casos, o termo adotado é o cuidado familiar. Para que o cuidado ampliado (autocuidado apoiado e cuidado familiar) ocorra com efetividade, o idoso e/ou seu cuidador, devem ter informação dos recursos disponíveis nos diversos níveis da saúde e da comunidade, contar com o apoio dos familiares, amigos e, principalmente, da equipe multiprofissional da atenção básica. Por sua vez, no idoso frágil e dependente, o conhecimento de toda tecnologia do cuidado tem papel decisivo na qualidade da assistência prestada pela família. O envolvimento ativo do idoso e de seu cuidador no gerenciamento das condições de saúde (doenças e incapacidades funcionais) tem papel decisivo na preservação e/ou melhoria da autonomia e independência e deve ser incluído no Plano de Cuidados Personalizado.

Referências Bibliográficas

- Aliberti MJR, Covinsky KE, Apolinario D et al. 10-Minute Targeted Geriatric Assessment Predicts Disability and Hospitalization in Fast-Paced Acute Care Settings. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2019, Vol. 74, No. 10, 1637–1642. doi:10.1093/gerona/glz109.
- Brasil. Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde do Foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada: SAÚDE DA PESSOA IDOSA (2019). Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2019.56 p.:il.
- Brasil. Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática/DAET. Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa/COSAPI. Brasília, Editora do Ministério da Saúde, 2014.
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de atenção domiciliar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.
- Briggs R, McDonough A, Ellis G, Bennett K, O'Neill D, Robinson D. Comprehensive Geriatric Assessment for community-dwelling, high-risk, frail, older people. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2022, Issue 5. Art. No.: CD012705. DOI: 10.1002/14651858.CD012705.pub2.
- British Geriatrics Society. Improving Healthcare for older people. 2019. Disponível em <https://www.bgs.org.uk/topics/cga-in-community-settings>. Acesso em 5 de janeiro de 2022.
- Camozzato AL, Kochhann R, Simeoni C, Konrath CA, Franz AP, Carvalho A, Chaves ML. Reliability of the Brazilian Portuguese version of the Neuropsychiatric Inventory (NPI) for patients with Alzheimer's disease and their caregivers. *International Psychogeriatrics*, 20(2):383-393, 2008.
- Carthery-Goulart M et al. Versão brasileira da Escala Cornell de Depressão na Demência (Cornell Depression Scale in Dementia). *Arq Neuropsiquiatr* 65(3-B):912-915, 2007.
- Choi JY, Rajaguru V, Shin J, Kim K. Comprehensive geriatric assessment and multidisciplinary team interventions for hospitalized older adults: A scoping review. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 104, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104831>
- Duarte YAO, Domingues MAR. Família, Rede de Suporte Social e Idosos: instrumentos de avaliação. Editora Edgard Blucher LTDA, 2020.
- Duarte, J. E.; Melo, R. V.; Azevedo, R. A. Cuidando do cuidador. In: Moraes, E. N. *Princípios Básicos de Geriatria e Gerontologia*. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. cap. 26, p. 371-379.
- Ellis G, Whitehead MA, O'Neill D, Langhorne P, Robinson D. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2011, Issue 7. Art. No.: CD006211. DOI: 10.1002/14651858.CD006211.pub2.
- Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, Seeman T, Tracy R, Kop WJ, Burke G, McBurnie MA. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001; 56(3):M146-156.
- Garrard JW, Cox NJ, Dodds RM et al. Comprehensive geriatric assessment in primary care: a systematic review. *Aging Clinical and Experimental Research* (2020) 32:197–205 <https://doi.org/10.1007/s40520-019-01183-w>.
- Maia FOM, Duarte YAO, Secoli SR et al. Adaptação transcultural do Vulnerable Elders Survey-13 (VES-13): contribuindo para a identificação de idosos vulneráveis. *Rev. Esc.enferm. USP*, 46 (Esp):116-22, 2012. <https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000700017>.
- Makizako H, Hir Shimada H, Tsutsumimoto K, Lee S, Doi T, Nakakubo S, Hotta R, Suzuki T. Social Frailty in Community-Dwelling Older Adults as a Risk Factor for Disability *JAMDA* 16 (2015) 1003.e7e1003.e11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2015.08.023>
- Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MRM, Oliveira MAC. Validação, no Brasil, do Índice de Barthel em idosos atendidos em ambulatorios. *Acta Paul Enferm*, 23(2):218-223, 2010.
- Moraes EN, Carmo JA, Lanna FM, Azevedo RS, Machado CJ, Romero DEM. Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20): reconhecimento rápido do idoso frágil. *Rev Saude Publica*, 50:81, 2016.
- Moraes EN, Carmo JA, Machado CJ, Lanna FM. Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20: proposta de classificação e hierarquização entre idosos identificados como frágeis. *Rev Fac Ciênc Méd Sorocaba*, 22(1):31-5, 2020. <https://doi.org/10.23925/1984-4840.2020v22i1a7>.
- Moraes EN, Lanna FM, Santos RR, Bicalho MAC, Machado CJ, Romero D. A New Proposal for the Clinical-Functional Categorization of the Elderly: Visual Scale of Frailty (VS-Frailty). *J Aging Res Clin Practice*, v.5 (1), p.24-30, 2016.
- Moraes EN, Reis AMM, Lanna FM. *Manual de Terapêutica Segura no Idoso*, Ed. Folium, 2019.
- Moraes E.N. *A Arte da (Des)Prescrição no Idoso: a dualidade terapêutica*. Ed. Folium, 2018.
- Moraes EN, Lanna F. Benefícios da Desprescrição para o Cuidado Seguro na Saúde do Idoso. In: *Conass Documenta. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: uma prioridade com múltiplas dimensões*. Brasília, 2023.
- Moraes E.N., Lanna F.M. *Guia de Bolso de Avaliação Multidimensional do Idoso*, Folium, Belo Horizonte. 5a ed, 2016.
- K. Rockwood et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. *CMAJ*, 113:489-495, 2005.
- Rodrigues MK, Rodrigues IN, Silva DJVG et al. Clinical Frailty Scale: translation and cultural adaptation into the Brazilian Portuguese Language. *The Journal of Frailty. Aging*, 10:38-43, 2021.
- Rubenstein LZ, Stuck AE, Siu AL, Wieland D. Impacts of Geriatric Evaluation and Management Programs on Defined Outcomes: Overview of the Evidence. *J Am Ger Soc*, 39S:85-16S, 1991.

- Saini V, Garcia-Armesto S, Klemperer D, Paris V, Elshaug AG, Brownlee S, et al. Drivers of poor medical care. *Lancet*. 2017; 390(10090): 178-90.
- Sanches MAS, Correa PCR, Lourenço RA. Cross-Cultural Adaptation of the "Functional Activities Questionnaire-FAQ" for use in Brazil. *Dement Neuropsychol*, 5(4):322-327, 2011.
- Santiago LM, Luz LL, Mattos IE, Gobbens RJJ. Adaptação transcultural do instrumento Tilburg Frailty Indicator (TFI) para a população brasileira. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, 28(9):1795-1801, set, 2012
- Santos IS, Tavares BF, Munhoz TN, Almeida LSP, Silva NTB, Tams BD, Patella AM, Matijasevish A. Sensibilidade e especificidade do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos da população geral. *Cad Saúde Pública*, 29(8):1533-1543, 2013.
- Saraiva MD, Venys AL, Abdalla FLP et al. AMPI-AB validity and reliability: a multidimensional tool in resource-limited primary care settings. *BMC Geriatrics*, 20:124, 2020. <https://doi.org/10.1186/s12877-020-01508-9>.
- Scazufca M. Brazilian version of the Burden Interview scale for the assessment of burden of care in carers of people with mental illnesses. *Rev Bras Psiquiatr*, 24(1):12-7, 2002.
- Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Recomendações para Diagnóstico e Tratamento da Sarcopenia no Brasil, 2022 (<https://www.academianonenutricao.com.br/pdf-material-cientifico/5006>).
- Veronesi N, Custodero C, Demurtas J et al. Comprehensive geriatric assessment in older people: an umbrella review of health outcomes. *Age and Ageing*, 51:1-9, 2022. <https://doi.org/10.1093/ageing/afac104>.
- VIDIGAL, M. J. M.; CASSIANO, J. G. Adaptação ambiental. In: Moraes, E.N. *Princípios básicos de geriatria e gerontologia*. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. cap. 8, p. 125-137.
- Yamada M, Arai H. Social Frailty Predicts Incident Disability and Mortality Among Community-Dwelling Japanese Older Adults *JAMDA* 19 (2018) 1099e1103. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.09.013>